KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ Ở

NHÓM NGƯỜI ĂN CHAY SO VỚI NHÓM CHỨNG KHỎE MẠNH

Châu Hữu Hầu

I. TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số như các số đo, huyết học, sinh hóa và một số xét nghiệm khác của nhóm người ăn chay so với nhóm chứng khỏe mạnh. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu**: Mô tả cắt ngang các trường hợp đến khám tại bệnh viện Nhật Tân từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến hết tháng 11 năm 2022. **Kết quả nghiên cứu**: Trong nghiên cứu của chúng tôi với 50 đối tượng ăn chay (trong đó nữ 39) được so sánh với nhóm chứng là 71 người (trong đó nữ 41). Có 4 kiểu ăn chay: 1) Kiểu ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa chiếm 48%; 2) thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm động vật kể cả uống mật ong và mặc áo lông thú 36%; 3) ăn chay nhưng được ăn trứng 12%; 4) các kiểu ăn chay khác 4%. Một số chỉ số khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nữ giới ăn chay so với nữ giới không ăn chay: chiều cao thấp; số lượng tiểu cầu cao; triglyceride tăng; uric acid giảm; prealbumin giảm. Ở nhóm nam ăn chay chỉ có một chỉ số duy nhất là HATTr tăng, trong khi HATT bình thường. **Kết luận**: Nhóm nữ ăn chay so với nữ không ăn chay: chiều cao thấp, lượng tiểu cầu cao, triglyceride tăng, uric acid giảm, prealbumin giảm. Ở nhóm nam ăn chay so với nam không ăn chay chỉ có một chỉ số duy nhất là HATTr tăng, trong khi HATT bình thường.

Từ khóa: Ăn chay có trứng, sữa; ăn chay có trứng; thuần chay
Viết tắt: HATTr, huyết áp tâm trương; HATT, huyết áp tâm thu

SUMMARY

SURVEY OF SOME INDICATORS IN GROUP OF VEGETARIAN EATERS VS HEALTHY CONTROL GROUP

Objective: To investigate a number of indicators such as anthropometric indices, hematology, biochemistry and some other tests of the vegetarian group compared with the healthy control group. **Methods**: Cross-sectional description of cases visiting Nhat Tan hospital from August 1, 2022 to November 30, 2022. **Results**: In our study with 50 subjects Vegetarian subjects (female 39) were compared with a control group of 71 people (female 41). There are 4 types of vegetarian without meat; 1) Lactoovo-vegetarian, but eating eggs and drinking milk accounts for 48%; 2) vegan, not eating all animal products including drinking honey and wearing fur with 36%; 3) ovo-vegetarian but eat eggs with 12%; 4) Other types of vegetarianism with 4%. Some indicators are statistically significant differences in vegetarian women compared to non-vegetarian women: short height; high platelet count; increased triglycerides; decreased uric acid; decreased prealbumin. In the vegetarian male group, there was

only one indicator that was increased diastolic blood pressure, while systolic blood pressure was normal. **Conclusion**: Vegetarian compared non-vegetarian women: short height, high platelet count, increased triglycerides, decreased uric acid, prealbumin decreased. Vegetarian compared non-vegetarian male: there was only one indicator that was increased diastolic blood pressure, while systolic blood pressure was normal.

Keywords: vegetarianism, flexitarian=semivegetarian, pescovegatarian=pescatarians, ovolactovegetarians, strick vegetarian=veganism.

1. MỞ ĐẦU

Trong gần 24 triệu năm tiến hóa, tổ tiên của con người gần như chỉ ăn chay, đôi khi còn ăn côn trùng. Về mặt giải phẫu, tổ tiên của con người đều có những đặc điểm như răng phẳng rộng và hàm di động hơn, giúp nhai ngũ cốc dễ dàng, rồi chuyển dần sang răng sắc nhọn và chuyển động của hàm theo trục thẳng đứng, dễ cho việc ăn thịt. [1]

Ngoài ra, động vật ăn thịt (carnivorous) có ruột ngắn hơn, giúp loại bỏ chất độc nhanh chóng, không giống như con người và các động vật chủ yếu ăn cỏ (herbivorous) khác, với ruột dài cho phép các quá trình tiêu hóa, lên men và hấp thụ diễn ra lâu hơn. [1]

Tuy nhiên, do lý do sinh tồn, tự vệ và bảo vệ lãnh thổ, vượn hình người bắt đầu săn bắt các loài khác, dẫn đến sự ra đời chế độ ăn thịt của Homo erectus và đây được xem là những thợ săn đầu tiên. Khả năng tồn tại của con người qua các loại thức ăn khác nhau là một yếu tố thiết yếu trong quá trình tiến hóa giúp loài Homo sapiens sapiens thích nghi với những điều kiện đa dạng nhất và lan rộng khắp hành tinh.

Trong thời kỳ đồ đá cũ, các loại thực phẩm khác nhau đã được tiêu thụ, chẳng hạn như thực vật hoang dã, hải sản, bò sát, chim và động vật có vú. Sau khi ra đời các tập quán nông nghiệp (khoảng 13.000 năm trước), thuần hóa động vật, kể cả để tiêu thụ, đã trở thành một hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, nông dân vẫn chủ yếu sống như người ăn chay do sự sẵn có của cây trồng. [1]

Ăn chay bắt nguồn từ những năm 3200 trước Công nguyên, Ai Cập cổ đại khởi đầu chế độ ăn chay do tin rằng kiêng thịt sẽ tạo điều kiện tái sinh (reincarnation). Về sau, ăn chay được phổ biến ở Ấn Độ với tín đồ đạo Hindu coi bò là vật linh thiêng. Các triết gia Hy Lạp cũng áp dụng chế độ ăn chay, mà Pythagore là một nhân vật hàng đầu. Việc bành trướng ăn chay đã gắn liền với các tôn giáo rao giảng sự tôn trọng đối với tất cả chúng sinh như Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, Đạo Sikh, Phật giáo, phong trào Hare Krishna và Nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm. Ngoài ra, trong thế kỷ 20 và 21, khoa học đã thấy một số vấn đề sức khỏe lợi ích liên quan đến giảm tiêu thụ thịt. Từ đó, nhiều người bị thu hút thực hành ăn chay trên toàn thế giới, và ngày càng tăng. [1]

Hiện tỷ lệ ăn chay trên toàn thế giới không đồng đều. Châu Á có tỷ lệ ăn chay cao nhất, với 19% dân số, Châu Phi và Trung Đông 16%; và ở miền Trung và Nam Mỹ, 8%. Tỷ lệ ăn chay thấp nhất ở Bắc Mỹ (6% dân số) và Châu Âu, chỉ 5% dân số. [1]

Có nhiều chế độ ăn chay: Kiểu ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa (*lacto-ovo)*; Kiểu ăn chay nhưng được ăn trứng (*ovo)*; Ăn chay không thịt nhưng được ăn cá (pesco-vegatarian = pescatarians); Ăn chay linh hoạt (flexitarian = semivegetarian), ăn thịt không thường xuyên, thí dụ 1 tuần 1 lần; Thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm động vật kể cả uống mật ong và mặc áo lông thú (*vegan)*

Lựa chọn chế độ ăn chay có thể mang lại kết quả tích cực: thể chất tốt hơn, cảm xúc tích cực do áp dụng thái độ đúng đắn về mặt đạo đức, tăng cảm giác thân thuộc (với cộng đồng ăn chay) và tác động môi trường thấp hơn. Tuy nhiên, các yếu tố khác có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người ăn chay do môi trường, nhóm xã hội/văn hóa, khác biệt giới tính, tiếp cận hạn chế với thực phẩm thực vật.[1]

Theo Romanowski và cs, qua phân tích tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ đáng kể của chế độ ăn chay so với tỷ lệ mắc và/hoặc tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ, và tỷ lệ mắc bệnh ung thư toàn bộ, nhất là chế độ thuần chay. [2]

Trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát một số chỉ số (các số đo, huyết áp, eGFR, huyết đồ, HbA_{1C}, cholesterol, triglyceride, uric acid, albumin, prealbumin, CRP, AST, ALT và GGT) của nhóm người ăn chay so với nhóm chứng khỏe mạnh.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Nhóm bệnh nhân ăn chay đến khám sức khỏe hay khám các bệnh thông thường: 50 người. **N**hóm chứng được chọn trong NVYT tình nguyện: 60 người. Nhưng do bệnh nhân ăn chay có tuổi đời cao hơn NVYT nên chúng tôi phải chọn thêm 11 bệnh nhân không ăn chay đang nằm viện vì các bệnh thông thường cho đủ số người trong nhóm chứng. Tổng cộng nhóm chứng được 71 người.

Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Thời gian nghiên cứu từ 01/8/2022 đến 30/11/2022, tại bệnh viện Nhật Tân, TP Châu Đốc, An Giang. Mỗi đối tượng được nghiên cứu đều được làm 1 phiếu có đầy đủ thông tin: tên họ, giới, tuổi, trình độ học vấn, ngày giờ khám, nhân trắc (cao, nặng, eo, mông), thói quen (hút thuốc, rượu…). Chế độ ăn chay: 1) Kiểu ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa (*lacto-ovo)*; 2) thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm động vật kể cả uống mật ong và mặc áo lông thú (*vegan*); 3) ăn chay nhưng được ăn trứng; 4) các kiểu ăn chay khác. Xét nghiệm máu (công thức máu, HbA1c, glucose, TSH, albumin, prealbumin, bộ mỡ, urê, creatinine, eGFR, AST, ALT, GGT, uric acid, CRP….

Xử lý số liệu: Dùng phần mềm thống kê SPSS 20.0, 2020. Dùng One-way ANOVA để so sánh 2 số trung bình. Trị số trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD). Trị số $p<0,05$ được xem có ý nghĩa thống kê.

Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được báo về nội dung, mục tiêu nghiên cứu. Mọi quyền lợi và thông tin cá nhân đều được bảo vệ. Các đối tượng ăn chay được miễn phí một phần hoặc hoàn toàn, nhóm chứng được miễn phí hoàn toàn.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. ***Số năm ăn chay***

Giới	Số người	Số năm ăn chay	Giới	Số người	Số năm ăn chay
Nữ	39	17,5 ± 10,4	Nam	11	16,6 ± 15,1

Nhận xét 1: Số năm ăn chay giữa nữ là 17,5±10,4 và nam 16,6±15,1, không khác biệt, p>0.05. số năm ăn chay trung bình, không phân biệt giới tính là 17,3 ± 11,4

Bảng 2. ***Giới tính có ăn chay hay không trong nghiên cứu***

Phân nhóm	Nữ giới		Nam giới		Cộng chung	
	Số người	Tỷ lệ %	Số người	Tỷ lệ %	Số người	Tỷ lệ %
Ăn chay	39	48,0%	11	26,8%	50	41,3%
Không ăn chay	41	51,2%	30	73,2%	71	58,7%
Cộng	80	100%	41	100%	121	100%

Nhận xét 2: Tổng số nữ 80, số ăn chay 39 (48,0%), nhóm chứng 41 (51,2%). Tổng số nam 41, số nam ăn chay 11 (chiếm 26,8%), số còn lại là nhóm chứng 30 (73,2%).

Bảng 3. ***Kiểu ăn chay***

TT	Kiểu ăn chay	N	Tỷ lệ %
1	Kiêng sản phẩm động vật, nhưng ăn trứng, uống sữa	24	48%
2	Thuần chay: kiêng tất cả sản phẩm động vật, kể cả mật ong, mặc áo lông thú...	18	36%
3	Kiêng sản phẩm động vật nhưng được ăn trứng	6	12%
4	Khác: Ăn chay linh hoạt (ăn chay 10 ngày/tháng)…	2	4%
Cộng		50	100%

Nhận xét 3: Ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa 48%; thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm động vật 36%; ăn chay nhưng ăn trứng 12%; các kiểu ăn chay khác 4%

Bảng 4. ***Phân bố giới tính có ăn chay hay không về trình độ, tuổi, khoảng tuổi***

Nữ giới	N	Trình độ		Tuổi	Khoảng tuổi	F	p
		≤ Tiểu học	≥Trung học				
Ăn chay	39	19 (48,7%)	20 (51,3%)	56,1 ± 8,7	40 -71	0,132	>0,05
Không ăn chay	41	14 (34,1%)	27 (65,9%)	55,2 ±12,5	40 - 92		

Nam giới	N	Trình độ		Tuổi	Khoảng tuổi	F	p
		≤ Tiểu học	≥Trung học				
Ăn chay	5	5 (100%)	0 (0%)	45,8 ± 14,5	18 - 68	0.022	>0,05
Không ăn chay	36	6 (16,7%)	30 (83,3%)	45,2 ± 9,6	27 - 62		

Nhận xét 4: ***Nữ giới:*** Trình độ ≤ tiểu học và ≥ trung học ở nhóm ăn chay tương đương nhau. Nhưng khác nhau ở nhóm không ăn chay vì trong nhóm này đa phần lớn là NVYT. So sánh tuổi và khoảng tuổi giữa 2 nhóm ăn và không ăn chay, không khác

biệt, p>0,05. ***Nam giới:*** Chỉ có 5 người nam ăn chay có trình độ ≤ tiểu học, không có trình độ ≥ trung học. Nhóm không ăn chay có trình độ khác nhau vì đa phần là NVYT. So sánh tuổi và khoảng tuổi giữa 2 nhóm có và không ăn chay, p>0,05.

Bảng 5. ***So sánh chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp và eGFR ở 2 giới và 2 chế độ ăn***

Nữ giới	Chiều cao	Cân nặng	BMI	HATTh	HATTr	eGFR
Ăn chay	1,52 ± 0.06	54,3 ± 8,4	17,8 ± 2,4	129,5 ± 14,6	81,0 ± 8.0	105,2 ± 22,9
Không ăn chay	1,55 ± 0.06	57,8 ± 8,5	18,7 ± 2,6	124.8 ± 12,8	79.6 ± 8.9	96,8 ± 32,0
F	F=4.560	F=3.365	F=0.376	F=2.370	F=0.559	F=1,800
Ý nghĩa	p <0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p>0,05

Nam giới	Chiều cao	Cân nặng	BMI	HATTh	HATTr	eGFR
Ăn chay	1,63±0.08 m	63,6 ± 13,2	19.5 ± 3,5	138,5 ± 39,0	91,0 ± 14,3	105,5 ± 18,0
Không ăn chay	1,65±0,05 m	65,5 ± 8,6	19,6 ± 2,4	125,8 ± 11,3	81,1 ± 7,4	107,5 ± 14,4
F	F=0.952	F=0.278	F= 0,128	F=3,936	F=8.502	F=0.126
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p <0,05	p>0,05

Nhận xét 5: ***Nữ giới***. Chỉ có chiều cao khác biệt giữa 2 nhóm có và không ăn chay, p <0,05. Cân nặng, BMI, HATT (huyết áp tâm thu), HATTr (HA tâm trương), eGFR không khác biệt, p >0.05. ***Nam giới***: có và không ăn chay có chiều cao, cân nặng, BMI, HATT và eGFR, p >0.05. Chỉ duy nhất có huyết áp tâm trương ở người nam ăn chay cao hơn người không ăn chay (91,0 ± 14,3 so với 81,1 ± 7,4) có ý nghĩa, p<0.05.

Bảng 6. ***Giới nữ có hay không ăn chay và các xét nghiệm huyết học***

Nữ giới	**Hồng cầu**	**Hemoglobin**	**Hematocrit**	**Bạch cầu**	**RDW**	**Tiểu cầu**
Ăn chay	4,41 ± 0,51	14,8 ± 16,7	40,3 ± 3,2	7,16 ± 1,58	12,9±1,2	321,0±61,7
Không ăn chay	4,34 ± 0.62	12,3 ± 1,6	41,4 ± 5,0	7,60 ± 2,53	14,5±6,7	286,8±75,1
F	F=0,261	F=0,877	F=1,172	F=0,880	F=1,692	F=4,931
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	P <0,05

Nam giới	**Hồng cầu**	**Hemoglobin**	**Hematocrit**	**Bạch cầu**	**RDW**	**Tiểu cầu**
Ăn chay	4,71 ± 0,63	13,6 ± 1,6	45,2 ± 4,80	7,16 ± 2,74	12,7 ± 0.6	234,4 ± 97,4
Không ăn chay	5,07± 0,56	14,3 ± 1.10	47,6 ± 3,10	7,01 ± 1,68	13,2 ± 3,4	256.9 ± 51,5
F	F=3,023	F=2,045	F=3,342	F=0,045	F=0,170	F=0,918
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05

Nhận xét 6: ***Giới nữ***: có hay không ăn chay có các xét nghiệm huyết học không khác biệt p >0,05. Chỉ có tiểu cầu ở nữ ăn chay cao hơn nữ không ăn chay (321,0±61,7 và 286,80±75,1), p >0.05. ***Giới nam***: có hay không ăn chay có các xét nghiệm huyết học tương tự, p >0,05.

Bảng 7. ***Giới nữ có ăn chay hay không và các xét nghiệm sinh hóa***

Nữ giới	**HbA1c**	**Total Chol**	**HDL-Chol.**	**LDL-Chol.**	**Triglycerid**	**Uric acid**
Ăn chay	6.47 ± 1,25	4,87 ± 0,89	1,22 ± 0,39	3.02 ± 0,74	2,39 ± 1,46	282,3 ± 68,0
Không ăn chay	6.46 ± 1,39	4,94 ± 0,95	1,27 ± 0,42	3,11 ± 0,88	1,67 ± 0,98	325,1 ± 68,2
F	F= 0,01	F= 0,132	F= 2,529	F= 0,194	F=6,703	F=7,911
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p <0,05	p <0,05

Nam giới	HbA1c	Total Chol.	HDL-Chol.	LDL-Chol.	Triglyceride	Uric acid
Ăn chay	6,28 ± 1,58	4,76 ± 1,61	1,21 ± 0,48	2,94 ± 1,56	1,98 ± 1,01	349,5 ± 75,2
Không ăn chay	6,20 ± 0,59	4,69 ± 0.84	1,20 ± 0,38	2,79 ± 0.82	2,31 ± 1,52	366,3 ± 81,8
F	F= 0,059	F= 0.031	F= 0,014	F= 0,178	F=0,453	F=0,352
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05

Nhận xét 7: ***Giới nữ***: có ăn chay hay không với các xét nghiệm HbA1c và bộ mỡ, p >0,05, trừ nồng độ triglyceride ở người nữ ăn chay cao hơn và uric acid thấp hơn so với người nữ không ăn chay, p <0.05. ***Giới nam***: có ăn chay hay không với các xét nghiệm HbA1c và bộ mỡ không khác biệt, p >0,05.

Bảng 8. ***Nữ giới có ăn chay hay không và các xét nghiệm khác***

Nữ giới	Albumin	Prealbumin	CRP	AST	ALT	GGT
Ăn chay	39,1 ± 2,1	26,3 ± 5,7	2,7 ± 3,1	23,9 ± 22,1	22,5 ± 28,8	50,2 ± 56,3
Không ăn chay	38,8 ± 2,4	28,9 ± 4,2	8,5 ± 25,4	21,4 ± 8,9	23,0 ± 15,6	42,6 ± 24,4
F	F=0,365	F=5,183	F=2,008	F=0,449	F=0,011	F=0,624
Ý nghĩa	p >0,05	p <0,05	P >0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05

Nam giới	Albumin	Prealbumin	CRP	AST	ALT	GGT
Ăn chay	40,2 ± 3,2	33,8 ± 13,2	3,98 ± 10,1	50,1 ± 80,8	43,4 ± 55,1	270,4±621,7
Không ăn chay	40,3 ± 2,5	34,3 ± 9,7	3,49 ± 13,3	26,1 ± 10,1	35,7 ± 22,6	66,6 ± 34,9
F	F=0,026	F=0,022	F=0.012	F=2,642	F=0,412	F=3,342
Ý nghĩa	p >0,05	p >0,05	p>0,05	p >0,05	p >0,05	p >0,05

Nhận xét 8: ***Nữ giới***: có ăn chay hay không có các xét nghiệm albumin, pre-albumin, AST, ALT và GGT, p >0.05. Chỉ duy nhất prealbumin ở nữ giới ăn chay thấp hơn nữ không ăn chay 26,3 ± 5,7 so với 28,9 ± 4,2 với p <0.05. ***Nam giới***: có ăn chay hay không có các xét nghiệm albumin, prealbumin, CRP, AST, ALT và GGT đều không khác biệt có ý nghĩa thống kê, p >0.05.

IV. BÀN LUẬN

Trong nghiên cứu của chúng tôi với 50 đối tượng ăn chay (trong đó nữ 39) được so sánh với nhóm chứng là 71 người (trong đó nữ 41). Kiểu ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa 48%; thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm thực vật kể cả uống mật ong và mắc áo lông thú 36%; ăn chay nhưng ăn trứng 12%; các kiểu ăn chay khác 4%. Chúng tôi nghĩ rằng số liệu thuần chay trong nghiên cứu này có thể chưa chính xác.

Số người ăn chay được đưa vào nghiên cứu là 50 (trong đó có 39 nữ), nhóm chứng có 71 người (trong đó nữ 41). Số năm ăn chay giữa nữ là 17,5±10,4 và nam 16,6±15,1, không khác biệt, p>0.05.

Nghiên cứu đối tượng có ăn chay hay không về trình độ, tuổi, khoảng tuổi

Tuổi và khoảng tuổi nghiên cứu giữa nữ và nam giới trong 2 nhóm ăn và không ăn chay, không có sự khác biệt với p>0,05. Điều này cho thấy phân nhóm ăn chay và

nhóm chứng đủ điều kiện để nghiên cứu. Ở nhóm nữ, trình độ ≤ tiểu học và ≥ trung học ở nhóm ăn chay tương đương với nhau, nhưng thấp hơn ở nhóm không ăn chay vì trong nhóm này có một phần lớn là NVYT. Về trình độ học vấn ở nhóm nam giới ăn chay có trình độ ≤ tiểu học, nhưng không có người nào có trình độ ≥ trung học, một phần do mẫu nhỏ. Nhưng trình độ khác nhau ở nhóm không ăn chay vì trong nhóm này NVYT chiếm đa số.

So sánh về chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp, eGFR

Giới nữ và nam có cân nặng, BMI, HATT (huyết áp tâm thu) và eGFR không khác biệt giữa 2 nhóm, với p >0.05. Nhưng giới nữ có chiều cao khác biệt giữa 2 nhóm ăn và không ăn chay, p <0,05, có thể do mẫu nhỏ. Và ở nhóm nam có huyết áp tâm trương ở người nam ăn chay cao hơn người không ăn chay (91,0 ± 14,3 so với 81,1 ± 7,4) khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0.05. Theo Lee và cs [3] chế độ ăn thuần chay làm giảm HATT và HATTr (huyết áp tâm trương), nhưng ở nhóm người ăn chay nhưng được ăn trứng và uống sữa (lacto-ovo), HATTr không giảm.

Các xét nghiệm huyết học giữa 2 đối tượng ăn chay và không ăn chay

Giới nữ và nam có ăn chay hay không ăn chay có các xét nghiệm huyết học tương tự như nhau, với p >0,05. Chỉ có số lượng tiểu cầu ở nữ ăn chay cao hơn nữ không ăn chay (321,0 ± 61,7 so với 286,8 ± 75,1), khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p <0.05, khác với nam giới khi so sánh giữa 2 nhóm tiểu cầu không khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p >0.05. Nghiên cứu của Tong và cs [4] ghi nhận những người ăn chay có số lượng tiểu cầu cao hơn nhưng có khối lượng tiểu cầu thấp hơn.

Các xét nghiệm sinh hóa giữa 2 đối tượng ăn chay và không ăn chay

Giới nữ và nam có ăn chay hay không ăn chay với các xét nghiệm HbA1c và bộ mỡ không khác biệt có ý nghĩa với p >0,05. Riêng nồng độ triglyceride ở người nữ ăn chay cao hơn và uric acid thấp hơn so với người nữ không ăn chay, p <0.05. Theo nghiên cứu của Wang F và cs [5] khi phân tích trên mạng 11 nghiên cứu thấy rằng chế độ ăn chay làm giảm đáng kể total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, nhưng không làm giảm triglyceride. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các choleterol không khác biệt ở người ăn chay với người không ăn chay. Nhưng triglyceride ở nhóm nữ ăn chay lại tăng có ý nghĩa thống kê, p<0.05. Theo Wang và cs chế độ ăn chay làm giảm cholesterol máu mà không ảnh hưởng đến nồng độ triglyceride trong máu [5]. Nữ giới ăn chay có nồng độ uric acid thấp hơn người không ăn chay, do chế độ ăn chay ít purin nhưng nên tránh một ít loài thực vật nhiều purin như đậu nành, rong biển, cải mù tạt có thể khiến độ uric acid máu tăng lên dù ăn toàn thực vật [6]. Nhưng ở nam giới nồng độ uric acid không khác biệt giữa người ăn và không ăn chay.

Các xét nghiệm suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn giữa 2 đối tượng ăn chay và không ăn chay

Nữ và nam giới có hay không ăn chay có các xét nghiệm albumin, AST, ALT và GGT đều không khác biệt có ý nghĩa thống kê, p >0.05. Chỉ duy nhất prealbumin ở nữ giới ăn chay thấp hơn nữ không ăn chay. Albumin huyết thanh có thời gian bán hủy dài nhất từ 18 đến 20 ngày, prealbumin có thời gian bán hủy ngắn từ 2-3 ngày, là các chỉ dấu suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn… CRP được sử dụng để giúp xác định liệu albumin, transferrin và prealbumin có bị giảm do quá trình viêm hay do suy dinh dưỡng. Ngoài ra các transaminase như AST, ALT và GGT cũng là các chỉ dấu về bệnh tim hay bệnh gan… [2] [8]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có prealbumin ở nữ giới ăn chay thấp hơn nữ không ăn chay. Các chỉ số khác ở nam và nữ đều không khác biệt có ý nghĩa thống kê, p >0.05.

Nghiên cứu của chúng tôi có số lượng nhỏ nên có thể có một số kết quả chưa được thuyết phục. Xếp kiểu ăn chay hình như chưa đúng với thực tế. Cần nghiên cứu sâu hơn với số lượng người tham gia nhiều hơn để có giải đáp tốt hơn.

Tóm lại, Trong nghiên cứu của chúng tôi với 50 đối tượng ăn chay (trong đó nữ 39) được so sánh với nhóm chứng là 71 người (trong đó nữ 41). Kiểu ăn chay nhưng ăn trứng, uống sữa chiếm 48%; thuần chay, không dùng tất cả sản phẩm thực vật kể cả uống mật ong và mắc áo lông thú: 36%; ăn chay nhưng được ăn trứng: 12%; các kiểu ăn chay khác 4%. Một số chỉ số khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nữ giới ăn chay so với nữ giới không ăn chay: chiều cao thấp; số lượng tiểu cầu cao; triglyceride tăng; uric acid giảm; prealbumin giảm. Ở nhóm nam ăn chay chỉ có một chỉ số duy nhất là HATTr tăng, trong khi HATT bình thường so với người không ăn chay.

V. KẾT LUẬN

Nữ giới ăn chay so với nữ giới không ăn chay: chiều cao thấp; số lượng tiểu cầu cao; triglyceride tăng; uric acid giảm; prealbumin giảm. Ở nhóm nam ăn chay chỉ có một chỉ số duy nhất là HATTr tăng, trong khi HATT bình thường.

THAM KHẢO

1. **Hargreaves SM, Raposo A, Saraiva A, Zandonadi RPZ.** Vegetarian diet: an overview through the perspective of Quality of life domains. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4067.
2. **Romanowski KS, Cochran A, Collins KA.** Clinical assessment and monitoring of nutrition support in adult surgical patients. UpToDate. Nov 2022.
3. **Lee KW, Loh HC, Ching SM, Devaraj NK, Hoo FK.** Effects of Vegetarian Diets on Blood Pressure Lowering: A Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis. Nutrients 2020, 12, 1604
4. **Tong TYN, Key TJ, Gaitskell K, Green TJ, Guo W, Sanders TA, Bradbury KE.** Hematological parameters and prevalence of anemia in white and British Indian vegetarians and nonvegetarians in the UK Biobank. Am J Clin Nutr 2019;110:461–472.

5. **Wang F; Zheng J; Yang B; Jiang J; Fu Y; Li D**. Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the American Heart Association 1 J Am Heart Assoc. 2015;4:e002408
6. **Jakše B, Jakše B, Pajek M, Pajek J.** Uric Acid and Plant-Based Nutrition. Nutrients 2019, 11, 1736.

ĐÁNH GIÁ ĐIỂM THƯƠNG TẬT THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

Đỗ Thị Quốc Trinh, Bùi Thị Xuân Vũ, Trần Thị Ngọc Liên,
Châu Hữu Hầu

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định điểm thương tật thần kinh (ĐTTTK) có nguy cơ cao ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2 và một số yếu tố nguy cơ liên quan tới tình trạng bệnh. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu**: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang trên 202 bệnh nhân mắc ĐTĐ típ 2 điều trị ngoại trú và bệnh nhân nằm viện trong 3 tháng từ 10/05/2022 đến 09/08/2022 tại Bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. **Kết quả**: Tỷ lệ người mắc ĐTĐ típ 2 có ĐTTTK nguy cơ cao là 20,8%. Bệnh nhân mắc ĐTĐ típ 2 lâu ngày có nguy cơ ĐTTTK cao, OR=1,12 (KTC95%, 1,06-1,18, p<0,001); chiều cao tăng cũng góp phần tăng ĐTTTK bàn chân, OR=1,12 (KTC95%, 1,05-1,19; p <0,001); đường huyết tăng làm cho ĐTTTK tăng, OR=1,00 (KTC95% từ 1,00-1,01, p <0,05); người càng nhẹ cân càng có ĐTTTK thấp hơn OR=0,91 (KTC95%, 0,87-0,96, p<0,001) và HDL-Cholesterol cao góp phần làm giảm ĐTTTK, OR=0,249 (KTC95%, 0,09-0,63, p<0,05). **Kết luận**: Nghiên cứu trên 202 bệnh nhân ĐTĐ típ 2 tại bệnh viện Nhật Tân phát hiện tỷ lệ có ĐTTTK nguy cơ cao (≥6) ở bàn chân là 20,8%. Các yếu tố nguy cơ liên quan tới ĐTTTK nguy cơ cao tỷ lệ thuận với chiều cao, cân nặng, số năm mắc ĐTĐ và mức đường huyết. Riêng nồng độ HDL-Cholesterol tỷ lệ nghịch với ĐTTTK nguy cơ cao. Cần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để điều trị, dự phòng các biến chứng nặng có thể gây tàn tật cho bệnh nhân

Từ khóa: Đái tháo đường típ 2 (ĐTĐ2), điểm thương tật thần kinh (ĐTTTK), âm thoa, 10g sợi đơn, tỉnh An Giang, bệnh viện Nhật Tân.

SUMMARY

EVALUATION OF NERVE INJURY SCORES OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND RISK FACTORS. Objective: Determine the Neuropathy Disability Score (NDS) at high risk in patients with type 2 diabetes to have appropriate treatment. **Subjects and Methods**: A prospective, cross-sectional study on 202 T2DM outpatients and inpatients for 3 months from May 10, 2022 to August 9, 2022 at Nhat Tan Hospital, Chau Doc city, An Giang province. **Results**: The rate of T2DM patients at high risk was 20.8%. Patients with long-term type 2 diabetes had a higher risk of NDS, OR=1.12 (CI 95%, 1.06-1.18, p<0.001); The increased height contributed to the increase in NDS of the feet, OR=1.12 (CI 95%, 1.05-1.19; p <0.001); increased blood sugar causes NDS to increase, OR=1.00 (95% CI 1.00-1.01, p < 0.05); The lower the weight, the lower the NDS, OR=0.91 (CI 95%, 0.87-0.96,

p<0.001) and high HDL-Cholesterol contributes to the reduction of NDS, OR=0.249 (CI 95%, 0.09-0.63, p<0.05). **Conclusion**: A study on 202 T2DM patients at Nhat Tan hospital found that the rate of NDS at high risk in the feet was 20.8%. NDS is proportional to height, weight, years of diabetes, and blood glucose levels. The higher the NDS, the higher these metrics. In contrast, HDL-Cholesterol levels are inversely proportional to GDM.

Key words: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), Neuropathy Disability Score (NDS), diapason, 10g monofilament, An Giang province, Nhat Tan hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo công bố của Liên đoàn Đái Tháo Đường Thế Giới vào năm 2021, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường toàn cầu ở lứa tuổi 20–79 ước tính là 10,5% (536,6 triệu người), tăng lên 12,2% (783,2 triệu người) vào năm 2045. Sự gia tăng tương đối lớn nhất về tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ từ năm 2021 đến năm 2045 dự kiến sẽ xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình (21,1%) so với các nước có thu nhập cao (12,2%) và thấp (11,9%). [1]

Trong một khảo sát tại Mỹ (2016-2017), tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ típ 2 được chẩn đoán ở người lớn là 8,5%; còn vào năm 2020, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường được chẩn đoán là khoảng 10,5% người trưởng thành. Với sự gia tăng rõ rệt tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em, người ta lo ngại rằng tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể. Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất trên thế giới, ước tính có khoảng 13% dân số trưởng thành mắc bệnh ĐTĐ, với khoảng một nửa không được chẩn đoán [2]. Tại Việt Nam, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, ngày 20/10/2017, Việt Nam có 3,5 triệu người trưởng thành mắc ĐTĐ, tương đương 6% dân số và dự kiến đến năm 2040 sẽ có 6,3 triệu người trưởng thành có thể mắc ĐTĐ. Trong đó có tới 70% người mắc ĐTĐ tại Việt Nam chưa được chẩn đoán.

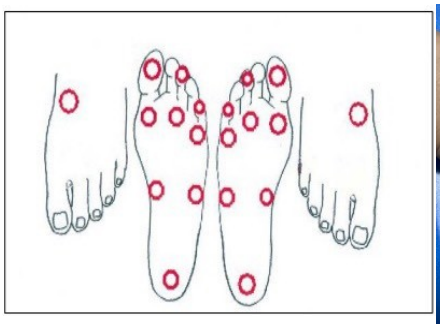
ĐTĐ típ 2 có một số triệu chứng kinh điển như đái nhiều, khát nhiều, ăn nhiều và giảm cân. Chẩn đoán ĐTĐ cần đến một số xét nghiệm: đường huyết lúc đói, đường huyết 2 giờ sau ăn và Hemoglobin A1c (HbA1c). Bệnh ĐTĐ típ 2 có một số các biến chứng cấp tính và mạn tính có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau; gây ra bệnh tật và có thể tử vong. Các biến chứng mạn tính được phân loại thành các bệnh mạch máu (vi mạch và mạch máu lớn) và các bệnh không do mạch máu. Biến chứng tại vi mạch bao gồm bệnh thần kinh, bệnh thận, và bệnh võng mạc, trong khi mạch máu lớn biến chứng bao gồm mạch máu não, bệnh lý mạch vành và bệnh động mạch ngoại vi [3]

Bệnh lý thần kinh do ĐTĐ ảnh hưởng đến 50% số người mắc ĐTĐ cả týp 1 và týp 2 với dạng bệnh đa và đơn dây thần kinh cũng như bệnh thần kinh tự trị. Bệnh lý thần kinh có liên quan đến thời gian mắc ĐTĐ và kiểm soát glucose trong máu. Loại bệnh lý thần kinh hay gặp nhất là viêm đa dây thần kinh đối xứng xa và các triệu chứng thường gặp là rối loạn cảm giác như tăng cảm giác, dị cảm. Để xác định các biến

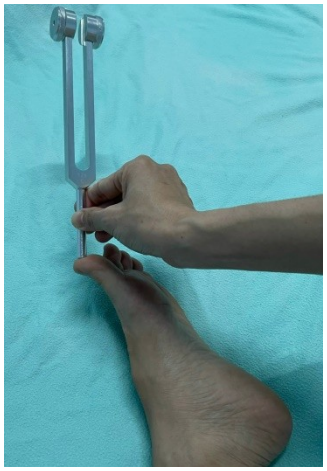
chứng của bệnh lý thần kinh trong bệnh ĐTĐ, cần phải sàng lọc và sau đó phân tầng theo mức độ của bệnh lý thần kinh. Một loạt các cuộc kiểm tra như Điểm Thương tật thần kinh (ĐTTTK) có thể được sử dụng để xác định mức độ của bệnh thần kinh. ĐTTTK bao gồm kiểm tra đâm kim (pinprick), phản xạ Achilles, nhiệt độ và cảm nhận rung động ở bệnh nhân. Kiểm tra NDS được thực hiện ở cả 2 bên và điểm ≥ 6 điểm được coi nguy cơ cao bất thường. ĐTTTK đã được chấp nhận rộng rãi và xác nhận là một công cụ giúp xác định sự hiện diện của bệnh thần kinh do ĐTĐ [3]. Tuy nhiên ở Việt Nam, chúng tôi chưa thấy có nghiên cứu nào đánh giá về ĐTTTK ở bệnh nhân ĐTĐ.

Bảng điểm thương tật thần kinh (ĐTTTK) [4]

Thử nghiệm	**Cho điểm**
Ngưỡng nhận cảm rung. Âm thoa 128-Hz đặt ở đỉnh ngón chân cái: bình thường=có thể phân biệt rung với không rung	***Ba ô bên trái được cho điểm như sau:*** Bình thường = 0 Bất thường = 1
Nhận cảm nhiệt. Trên lưng bàn chân, âm thoa + cốc đá lạnh/nước ấm	
Đâm kim. Áp kim gần móng ngón chân cái vừa đủ để làm biến dạng da; Vạch đôi =nhọn, tù; bình thường = có thể phân biệt nhọn hoặc không	
Phản xạ Achilles. [a]Kỹ thuật tăng cường Jendrassik: bệnh nhân uốn cong các ngón của 2 bàn tay thành dạng như móc câu, và đan các ngón tay đó lại với nhau rồi kéo mạnh. Sau đó, gõ vào gân Achiles để tạo ra phản xạ.	Có =0 Có khi tăng cường[a] =1 Không =2
Cộng điểm cả 2 bên. Nếu điểm ≥6 coi là "Bất thường"	***Tổng điểm*** *=10*







H1 Trái. *Sơ đồ 10 điểm kiểm tra*
H2.Giữa.*Đo 10g monofilament*
H3. ***Phải.*** *Đo nhận cảm rung*

10g monofilament

Nghiên cứu này nhằm mô tả tình trạng ĐTTTK của bệnh nhân ĐTĐ típ 2, cũng như xác định một số yếu tố nguy cơ của tình trạng bệnh lý này ở người bệnh ĐTĐ típ 2.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu: Những bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh ĐTĐ típ 2 đến khám bệnh và điều trị tại bệnh viện Nhật Tân; đồng ý tham gia nghiên cứu. **Đối tượng loại trừ**: Những người không đồng thuận tham gia nghiên cứu, các phiếu thu thập không đủ số liệu nghiên cứu.

2.2 Thời gian & Địa điểm: Nghiên cứu trong 3 tháng, từ 10/05/2022 cho đến 09/08/2022; tại Bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu tối thiểu ước lượng một giá trị trung bình, áp dụng trên 1 nhóm đối tượng : N . Trong đó độ tin cậy 95%; σ: độ lệch chuẩn được cho là 5 mmHg; E: tỷ lệ sai số giữa mẫu và quần thể chung là 0,1. N sẽ là 96. Trên thực tế số lượng người bệnh nghiên cứu của chúng tôi là 202.

2.4 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang loạt ca bệnh, tiến cứu ở từng ca bệnh.

2.5. Công cụ nghiên cứu:

- *Biểu mẫu thu thập số liệu:*

Phần hành chánh, nhân trắc (chiều cao, cân nặng, vòng eo, mông); thói quen sinh hoạt (rượu, thuốc lá); thời gian mắc ĐTĐ; trị số huyết áp tâm thu, tâm trương; xét nghiệm sinh hóa máu (HbA1c, glucose, Total cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride, urê, creatinine); các loại thuốc ĐTĐ và số lần uống thuốc; các bệnh đi kèm.

- *Đánh giá chức năng thần kinh:* Ngoài đánh giá tình trạng da và cơ xương khớp bằng thăm khám thực thể (đâm kim, phản xạ gân Achilles…) còn phải đánh giá:
  - Nhận cảm rung động và nhận cảm nhiệt bằng âm thoa 128-Hz
  - Cảm giác bằng 10 g monofilament test trên 10 điểm ở bàn chân theo sơ đồ (H1)

2.6 Phương pháp tiến hành

- ***Tại buồng khám của Bệnh viện:*** Đối tượng nghiên cứu (BN ngoại trú) là bệnh nhân đã được chẩn đoán ĐTĐ típ 2 tái khám theo lịch hẹn tại Phòng khám và có đủ các xét nghiệm theo yêu cầu (HbA1c, glucose, Total cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride, urê, creatinine, eGFR). Bệnh nhân được đo các chỉ số chiều cao, cân nặng, chỉ số huyết áp và trả lời theo bảng câu hỏi về thói quen (rượu, thuốc lá), thời gian mắc ĐTĐ, các loại thuốc ĐTĐ đã dùng và các bệnh đi kèm. Bệnh nhân được khám bàn chân và thực hiện các test kiểm tra đâm kim, cảm giác nhiệt, cảm giác rung âm thoa, phản xạ gân Achilles, thử nghiệm monofilament và bắt mạch động mạch chày trước, động mạch chày sau ở cả hai bàn chân.

- ***Tại khoa nội trú:*** Cũng tương tự bệnh nhân khám ngoại trú, các bệnh nhân nội trú được chọn bao gồm cả bệnh nhân đã bị ĐTĐ chẩn đoán trước đó và người bệnh ĐTĐ mới được phát hiện. Toàn bộ các chỉ số nghiên cứu được thực hiện đầy đủ như đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú.

2.7. Xử lý số liệu: Tất cả dữ liệu đã được nhập và phân tích trong SPSS (phiên bản 20). Dùng crosstabs để kiểm định các biến định tính. Dùng One-way ANOVA để so sánh 2 số trung bình. Dùng hồi qui logistic khi chọn ĐTTTK là biến phụ thuộc để phân tích các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến ĐTTTK. Sử dụng trị số trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD). Trị số $p<0,05$ được xem có ý nghĩa thống kê.

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được thông báo chi tiết về nội dung, mục tiêu nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi quyền lợi của người bệnh và thông tin cá nhân đều được bảo vệ.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Bảng 3.1. ***Đánh giá điểm thương tật thần kinh ở bệnh nhân ĐTĐ theo Boulton [4]***

Tổng số điểm cả 2 chân			**Tổng điểm cả 2 chân NDS ≥6**
Điểm	***Số ca (Tổng số 202)***	***Xếp theo 4 cấp độ***	***Xếp theo 2 nhóm nguy cơ***
0	35	Bình thường 54 (26,7%)	Nguy cơ thấp 160 (79,2%)
1	2		
2	17		
3	2	Nhẹ 106 (52,5%)	
4	104		
5	0		
6	34	Trung bình 40 (19.8%)	Nguy cơ cao 42 (20,8%)
7	2		
8	4		
9	0	Nặng 2 (1%)	
10	2		

Nhận xét: Bảng ĐTTTK ở bệnh nhân ĐTĐ cải tiến của Boulton, dựa vào nghiên cứu của châu Âu. Tổng điểm cả 2 chân là 10 và nếu ĐTTTK ≥6 thì có nguy cơ gia tăng về loét bàn chân vô cảm. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân ĐTĐ được chia làm 2 nhóm: <6 có nguy cơ loét chân thấp với 160 bệnh nhân (79,2%) và ≥6 có nguy cơ loét chân cao với 42 bệnh nhân (20,8%).

Bảng 3.2. Phân tích các biến định lượng bằng ANOVA với biến phụ thuộc là ĐTTTK

Nguy cơ / Các chỉ số	Nguy cơ cao (n=42)			Nguy cơ thấp (n=160)			F	p
	Trung bình	Tối thiểu	Tối đa	Trung bình	Tối thiểu	Tối đa		
Tuổi (năm)	63,5 ± 11,1	42	90	61,2 ± 9,9	36	93	1,68	0,196
Chiều cao cm	158,1 ± 9,2	143	183	155,5 ± 7,0	142	175	4,05	**0,045**
Cân nặng kg	57,2 ± 10,1	40,1	80,3	61,7 ± 11,0	39,6	105	5,74	**0,017**
BMI	22,9 ± 3,5	15,0	30,0	25,5 ± 3,8	16,9	34,7	16,1	**0,000**
Số năm mắc ĐTĐ	11,9 ± 8,7	0	36	6,6 ± 6,1	0	30	20,3	**0,000**
HA tâm thu mmHg	137 ± 16,3	112	184	134 ± 25,9	50	210	0,48	0,488
HA tâm trương mmHg	82,3 ± 10,4	67	115	82,5 ± 10,6	54	120	0,01	0,933
HbA1c	9,5 ± 2,4	6,6	14,0	9,1 ± 2,5	5,0	16,5	0,8	0,37
Glucose	205 ± 108	40	524	173 ± 100	9,8	866	3,28	0,071
Total Cholesterol	4,65 ± 1,32	2,50	7,50	4,77 ± 3,33	2,20	42,8	0,17	0,678
LDL-Cholesterol	2,61 ± 1,14	0,17	5,20	2,51 ± 1,16	0,20	3,30	0,26	0,609
HDL-Cholesterol	1,14 ± 0,38	0,50	2,10	1,37 ± 0,53	0,50	3,30	6,69	**0,010**
Triglyceride	2,70 ± 1,27	0,80	7,50	3,30 ± 11,9	0,70	151	0,10	0,746
Urê	4,89 ± 4,29	5,00	19,0	4,22 ± 6,02	10,0	66,0	0,45	0,503
Creatinine	92,5 ± 64,7	34	366	77,6 ± 28,5	37	247	4,90	**0,028**
Tổng số bệnh kèm	1,60 ± 1,08	0	4	1,80 ± 1,10	0	5	1,27	0,261

Nhận xét: Chỉ có các chỉ số: chiều cao, cân nặng, BMI, số năm mắc ĐTĐ. HDL-cholesterol, creatinine máu là có ý nghĩa với ĐTTTK nguy cơ cao (≥6), với p <0,05.

Bảng 3.3 Phân tích các biến định tính với crosstables có nguy cơ cao ĐTTTK≥6

Danh mục		Điểm TTTK ở BN ĐTĐ				χ^2	p
		ĐTTTK ≥6		***ĐTTTK <6***			
		Số ca	Tỷ lệ %	Số ca	Tỷ lệ %		
Giới tính	Nữ	29	21,0	109	79,0	0,013	>0,05
	Nam	13	20,3	51	79,7		
Trình độ học vấn	Tiểu-trung học	32	22,8	108	77,1	1,181	>0,05
	Đại học	10	16,1	52	83,9		
Thuốc lá	Có Không	7 35	20,6 20,8	27 133	79,4 79,2	0,001	>0,05
Rượu bia	Có Không	6 36	16,7 21,7	30 130	83,3 78,3	0,453	>0,05
Uống thuốc đều	Không Có	37 5	20,4 23,8	144 16	79,6 76,2	0,130	>0,05
Giảm ăn	Không Có	32 10	20,9 20,4	121 39	79,1 79,6	0,006	>0,05

Thể dục đều mỗi ngày	Không Có	39 3	22,8 9,7	132 28	77,2 90,3	2,747	>0,05
Giảm cân	Không Có	42 0	21,8 0,0	151 9	78,2 100,0	2,473	>0,05

Nhận xét: Tất cả các biến định tính trên khi phân tích bằng crosstabs và cả hồi qui logistic theo mức độ nguy cơ (cao, thấp) đều không có ý nghĩa thống kê với p >0,05

Bảng 3.4. Kết quả phân tích hồi qui logistic có 5 yếu tố có ý nghĩa thống kê

Yếu tố	OR	Khoảng tin cậy 95%	Giá trị p
Năm mắc ĐTĐ	1,12	1,06-1,18	0,001
Chiều cao	1,12	1,05-1,19	0,001
Đường huyết	1,00	1,00-1,01	0,023
Cân nặng	0,91	0,87-0,96	0,001
HDL-C	0,249	0,09-0,63	0,003

Nhận xét: Các biến định lượng và định tính được phân tích bằng hồi qui logistic đa biến với biến phụ thuộc là ĐTTTK (cao, thấp) thì chỉ còn 5 yếu tố nguy cơ có ý nghĩa: số năm mắc ĐTĐ, chiều cao, đường huyết, cân nặng và HDL-cholesterol.

IV. BÀN LUẬN

4.1. Về tỷ lệ mắc thương tật thần kinh ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ người có ĐTTTK nguy cơ cao ≥6 do ĐTĐ típ 2 là 20,8%. Nghiên cứu của Kaoje YS và cs ở Nigeria trên 330 bênh nhân ĐTĐ thì có điểm ĐTTTK bình thường là 54,8%, nhẹ 8,8%, trung bình 30,3% và nặng 6,1%. Như vậy số bệnh nhân có ĐTTTK ≥6 là 36,4%. Tác giả đã dẫn chứng các nghiên cứu khác cũng ở châu Phi như ở Kano, Tây Bắc Nigeria, Ibrahim và cs thì tỷ lệ này là 30% [5]. Các số liệu này đều cao hơn nghiên cứu của chúng tôi. Sự khác biệt có thể do cách lấy mẫu, phương pháp chẩn đoán, khác biệt về chủng tộc, môi trường…

4.2. Các yếu tố nguy cơ của ĐTTTK ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2

Trong đánh giá ĐTTTK bệnh nhân ĐTĐ típ 2, có 5 yếu tổ ảnh hưởng đến bệnh lý này: chiều cao, cân nặng, năm mắc ĐTĐ, mức đường huyết và HDL-Cholesterol, đều có ý nghĩa thống kê với p <0,05.

- ***Về thời gian mắc bệnh ĐTĐ***

Mắc bệnh ĐTĐ càng lâu, càng có nhiều ĐTTTK nguy cơ cao (≥6) trong nghiên cứu của chúng tôi, với OR=1,12 (KTC95%, 1,06-1,18, p<0,001). Nghiên cứu của Kiani tại Iran cũng có OR=1,072 (KTC95%, 1,056-1,087) [6]

- ***Về chiều cao của người bệnh***

Theo nghiên cứu của chúng tôi chiều cao của bệnh nhân tỷ lệ thuận với ĐTTTK ≥6 ở

bệnh nhân ĐTĐ, với OR=1,12 (KTC95%, 1,05-1,19; p <0,001). Phát hiện này cũng đã được ghi nhận trong một nghiên cứu ở Ấn Độ vào năm 2019, Sujjay và cs nhận thấy tỷ lệ mắc bệnh thần kinh vô cảm ngoại biên là 3,2% khi khảo sát 760 bệnh nhân đến khám bệnh trên 30 tuổi. Tỷ lệ này thấp do chọn tất cả bệnh nhân đến khám bệnh, gồm cả người ĐTĐ và tiêu chuẩn khám có phần khác với ĐTTTK ở bệnh nhân ĐTĐ. Khi chiều cao tăng lên, tỷ lệ ĐTTTK ≥6 tăng lên, bất kể các yếu tố nguy cơ độc lập khác như bệnh đi kèm, tăng huyết áp, v.v ... Bệnh ĐTĐ và tăng huyết áp cũng được coi là các yếu tố rủi ro độc lập quan trọng [7]. Chiều cao có thể là một chỉ dẫn giúp các chuyên gia chăm sóc xác định bệnh nhân ĐTĐ có ĐTTTK nguy cơ cao (≥6).

- ***Về đường huyết***

Tăng đường huyết là triệu chứng thường xuyên, quan trọng nhất ở người bệnh ĐTĐ, nó gây ra stress oxy hóa tế bào thần kinh của bệnh nhân và dẫn đến kích hoạt nhiều con đường sinh hóa. Sự kích hoạt này là nguồn gây tổn thương chính và là mục tiêu điều trị tiềm năng cho bệnh thần kinh do ĐTĐ. Tuy một số nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa việc tăng HbA1c và glucose với ĐTTTK, nhưng nghiên cứu của chúng tôi thì HbA1c không liên quan có ý nghĩa với ĐTTTK nguy cơ cao, trong khi glucose máu có ý nghĩa nhưng yếu với OR=1,00 (KTC95%, 1,00-1,01, p <0,05).

- ***Về cân nặng người bệnh***

Nghiên cứu này cho thấy người càng nhẹ cân, càng có tỷ lệ ĐTTTK thấp hơn, với OR=0,91 (KTC95% từ 0,87 đến 0,96, p<0,001). Nghiên cứu của Kiani tại Iran cũng có kết quả tương tự, nhưng theo chiều hướng càng nặng cân càng có ĐTTTK cao hơn với OR=4,06 (KTC95%, 1,00-1,03, p=0,0044) [7]

- ***Về HDL-Cholesterol***

Trong nghiên cứu của chúng tôi HDL-Cholesterol là yếu tố liên quan có giá trị bảo vệ giảm ĐTTTK nguy cơ cao (≥6), người có HDL-Cholesterol càng cao, càng có ĐTTTK thấp hơn với OR=0,249 (KTC95% từ 0,09 đến 0,63, p<0,05). Nghiên cứu của Cai và cộng sự ở Trung Quốc nhận thấy nồng độ HDL-C huyết thanh cao làm giảm nguy cơ ĐTTTK (OR=0,85, KTC 95%: 0,75–0,96), trong khi nồng độ Total Cholesterol không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm nghiên cứu (OR = 1,02, KTC 95%: 1,00–1,04) [8]. Phân tích tổng hợp này chỉ ra rằng sự thay đổi thành phần lipid huyết thanh là một trong những đặc điểm sinh học của người bệnh ĐTĐ, qua đó giúp bác sĩ lâm sàng lựa chọn liệu pháp thích hợp để tối ưu hóa việc điều trị.

Ngoài ra các yếu tố khác như BMI, huyết áp, HbA1c, các cholesterol có hại, urê, creatinine, bệnh đi kèm, giới tính, trình độ học vấn, hút thuốc, uống rượu bia, tuân thủ uống thuốc, giảm ăn, thể dục, giảm cân… đều không có ý nghĩa thống kê.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu trên 202 bệnh nhân ĐTĐ típ 2 tại một bệnh viện ở Châu Đốc, An Giang phát hiện tỷ lệ có ĐTTTK ≥6 ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 là 20,8%. Các yếu tố nguy cơ tỷ lệ thuận với ĐTTTK nguy cơ cao gồm chiều cao, cân nặng, số năm mắc ĐTĐ, mức đường huyết. Riêng nồng độ HDL-Cholesterol tỷ lệ nghịch với ĐTTTK nguy cơ cao.. Cần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ này để điều trị và dự phòng các biến chứng nặng có thể gây tàn tật cho bệnh nhân.

THAM KHẢO

1. **Sun H, Saeedi P, Karuranga S, Pinkepank M et al.** IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes research and clinical practice 183 (2022) 109-119
2. **Robertson RP, Nathan DM, Mulder JE.** Type 2 diabetes mellitus: Prevalence and risk factors. UpToDate. Jan 25, 2022.
3. **Hunaifi I, Agustriadi IGNO, Asmara IGY, Budyono C.** The Correlation Between HbA1c and Neuropathy Disability Score in Type 2 Diabetes . Acta Med Indones - Indones J Intern Med • Vol 53 • Number 2 • April 2021
4. **Boulton AJM.** Management of Diabetic Peripheral Neuropathy. Clinical Diabetes • Volume 23, No 1, 2005
5. **Kaoje YS , Bello F , Bansi IK , Bakari AG, Yakubu IM, Lawal Y.** Prevalence and severity of distal symmetrical polyneuropathy among patients with type 2 diabetes mellitus in Zaria, Nigeria. Diabetes Updates, 2020, Volume 6: 1-4
6. **Kiani J, Moghimbeigi A, Azizkhani H, Kosarifard S.** The prevalence and associated risk factors of peripheral diabetic neuropathy in Hamedan, Iran. 2013 Jan;16(1):17-9.
7. **Sujjay J, Green SR, Kasim K.** Height is a risk factor for development of peripheral insensate neuropathy. Medicine Int J Adv Med. 2019 Jun;6(3):860-866.
8. **Cai Z, Yang Y, Zhang J**. A systematic review and meta-analysis of the serum lipid profile in prediction of diabetic neuropathy. Scientifc Reports | (2021) 11:499.

TỶ LỆ ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2021

Châu Thiên Bình, Ngô Phi Nhựt Thi, Châu Hữu Hầu

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đái tháo đường là bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi tình trạng gia tăng đường huyết trong thời gian dài cùng với sự mất cân bằng chuyển hóa trong cơ thể do đề kháng insulin hoặc khuyếm khuyết tiết insulin hoặc cả hai. Trong thế kỷ 21, bệnh đái tháo đường ngày càng được công nhận là một trong những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người, do tỷ lệ mắc bệnh gia tăng đáng kể cùng với xu hướng ngày càng trẻ hóa trong những năm gần đây và là nguyên nhân chính của nhiều biến chứng mạn trên tim mạch và bệnh thận đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế năm 2021, trên toàn cầu có hơn 1/10 người trưởng thành hiện đang sống với bệnh đái tháo đường. Nhiều quốc gia có đến 1/5 dân số mắc bệnh bệnh đái tháo đường hoặc thậm chí còn nhiều hơn. Người ta tính rằng hơn 6,7 triệu người trong độ tuổi từ 20–79 sẽ chết vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh đái tháo đường vào năm 2021, mức chi tiêu trực tiếp cho y tế do bệnh đái tháo đường đã lên tới gần một nghìn tỷ Mỹ kim và sẽ vượt quá con số này vào năm 2030 [6].

Tuy nhiên, kết quả điều trị bệnh đái tháo đường phụ thuộc vào bác sĩ, dược sĩ, thuốc, bệnh nhân và nhiều yếu tố khác nhau. Việc đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và các yếu tố liên quan tại bệnh viện là rất cần thiết để chúng tôi xem xét lại vấn đề điều trị. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với 02 mục tiêu:

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết Bệnh viện Nhật Tân năm 2021.

2. Xác định tỷ lệ đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết Bệnh viện Nhật Tân năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2 đang điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết Bệnh viện Nhật Tân từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021.

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ĐTĐ típ 2 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh ĐTĐ típ 2 của Bộ Y tế năm 2020 [1], đang điều trị

ngoại trú và được quản lý tại phòng khám nội tiết, có khả có khả năng giao tiếp và đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện hoặc đang được điều trị tại phòng khám nhưng dưới 03 tháng; đái tháo đường thai kỳ; đái tháo đường típ 1; bệnh nhân đang mang thai hoặc cho con bú.

2.2. Phương pháp nghiên cứu:

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang và tiến cứu.

Cỡ mẫu nghiên cứu: được tính theo công thức ước lượng một tỷ lệ

$$n = Z^2_{1-\alpha/2} \frac{p(1-p)}{d^2}$$

p là tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ típ 2 đạt mục tiêu HbA1c <7%. Dựa trên nghiên cứu của chương trình đánh giá ĐTĐ liên châu Á tại Việt Nam tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c <7% là 30% [12], p lấy bằng 0,3.

Với α =0,05, Z =1,96, d = 0,05. Tính được n tối thiểu là 323 bệnh nhân. Để bù cho số mẫu thất thoát, chúng tôi lấy thêm 5% số mẫu tối thiểu nên số bệnh nhân thực tế thu được là 340 người.

Nội dung nghiên cứu:

- Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: tuổi, giới, trình độ học vấn.
- Đặc điểm lâm sàng: thời gian mắc bệnh ĐTĐ típ 2, bệnh đồng mắc, thể trạng (BMI, vòng eo), thuốc điều trị.
  - Chỉ số BMI (Body Mass Index) được tính như sau: lấy cân nặng (Kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Dựa trên thang phân loại của WHO áp dụng cho người châu Á, BMI gồm 6 giá trị:
    + Gầy: BMI dưới 18,5
    + Bình thường: BMI từ 18,5 đến 22,9
    + Thừa cân: BMI từ 23 đến 24,9
    + Béo phì độ I: BMI từ 25 đến 29,9
    + Béo phì độ II: BMI trên 30
  - Vòng eo, căn cứ vào ngưỡng giới hạn nguy cơ về vòng eo của WHO [16] có 2 giá trị:
    + Bình thường (nam <94cm; nữ <80cm)
    + Cao (nam ≥94cm; nữ ≥80cm)
- Đặc điểm cận lâm sàng:
  - Glucose đói: phân tích trên máy sinh hóa tự động Roche Cobas c501
  - HbA1c: phân tích trên máy Tosho G8
- Thuốc điều trị bệnh ĐTĐ
  - Tỷ lệ các thuốc điều trị bệnh ĐTĐ

- Phác đồ điều trị bệnh ĐTĐ

- Một số thói quen của đối tượng nghiên cứu:

- Hoạt động thể lực: Sử dụng bảng câu hỏi hoạt động thể lực toàn cầu GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire) được phát triển bởi tổ chức Y tế Thế giới WHO [15]. Hoạt động thể lực (HĐTL) được đánh giá bằng năng lượng chuyển hóa tương đương MET (Metabolic Equivalents).
  + Hoạt động thể lực đủ: ≥600 MET-phút/tuần
  + Hoạt động thể lực chưa đủ <600 MET-phút/tuần
- Tuân thủ dùng thuốc: Sử dụng thang đánh giá tuân thủ điều trị thuốc Morisky gồm 8 câu [14].
  + Tuân thủ (7-8 điểm)
  + Không tuân thủ (0-6 điểm)
- Tuân thủ chế độ ăn: sử dụng bộ câu hỏi tuân thủ chế độ ăn bộ câu hỏi PDAD (Patient Diet Adherence in Diabetes) [10], gồm có 20 hành vi trong bộ câu hỏi tương đương với 20 điểm.
  + Tuân thủ tốt >10
  + Tuân thủ kém ≤10.

- Xác định tỷ lệ đạt mục tiêu đường huyết
  - Quy ước thời gian lấy mẫu như sau:
    + Thời điểm T0: thời điểm
    + Thời điểm T3: sau 3 tháng điều trị
  - Căn cứ vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 của Bộ Y tế năm 2020 [1], chúng tôi đánh giá các chỉ số như sau:
    + Glucose đói: <7,2 mmol/L: đạt mục tiêu glucsos đói
    + HbA1c <7%: đạt mục tiêu HbA1c
    + Glucose đói: <7,2 mmol/L và HbA1c <7%: đạt mục tiêu đường huyết glucsose đói và HbA1c
- Một số yếu tố liên quan với kiểm soát HbA1c đạt mục tiêu: Nhóm tuổi, giới, trình độ, thời gian mắc bệnh ĐTĐ, tuân thủ chế độ ăn, tuân thủ chế độ dùng thuốc, hoạt động thể lực, BMI, vòng eo, thuốc sử dụng.

Xử lý số liệu:

Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0

Thống kê mô tả: các biến số phân hạng được biểu diễn bằng tỉ lệ %. Các biến số liên tục phân phối chuẩn được biểu thị bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (±SD).

Phân tích thống kê: Tính OR và kiểm định chi bình phương, hồi quy logistic đa biến tìm yếu tố độc lập liên quan. Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê nếu p<0,05.

2.3. Đạo đức trong nghiên cứu:

Nghiên cứu được tiến hành đúng nguyên tắc về đạo đức trong y học. Việc thu thập thông tin bằng các phiếu khảo sát có giải thích đầy đủ cho bệnh nhân biết về mục đích và nội dung và được sự đồng thuận từ phía bệnh nhân và người nhà.

Nghiên cứu được thực hiện sau khi được sự phê duyệt của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Ban Giám đốc Bệnh viện Nhật Tân.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm	Giá trị	n=340	Tỷ lệ %
Giới tính	Nam	103	30,3
	Nữ	237	69,7
Trình độ học vấn	Mù chữ, tiểu học	212	62,4
	Trên tiểu học	128	37,6
Nhóm tuổi	<60	191	56,2
	≥60	149	43,8
	SD: 58,3±10,0 Cao nhất: 86 Thấp nhất: 28		

Nhận xét: Bệnh nhân nữ chiếm 69,7%. Nhóm có trình độ mù chữ, tiểu học chiếm tỷ lệ 62,4%. Độ tuổi mắc bệnh ĐTĐ típ 2 trong mẫu nghiên cứu trung bình là 58 tuổi, nhỏ nhất 28 tuổi, lớn nhất 86 tuổi, nhóm tuổi < 60 chiếm 56,2%.

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm	Giá trị	n=340	Tỷ lệ %
Thời gian mắc bệnh	<5	144	42,4
	≥5	196	57,6
	±SD: 7,31±5,85 Cao nhất: 34 Thấp nhất: 1		
Bệnh đồng mắc	Tăng huyết áp	264	77,6
	Rối loạn lipid	225	66,2
	Bệnh khác	175	51,5
BMI	<18,5: gầy	6	1,8
	18,5-22,9:bình thường	103	30,3
	23-24,9: thừa cân	69	20,3
	25-29,9: béo phì độ I	134	39,4
	≥30: béo phì độ II	28	8,2
	±SD: 24,9±3,7 Cao nhất: 40 Thấp nhất: 16		
Vòng eo	Trên ngưỡng (nam ≥94; nữ ≥80cm)	212	62,4
	Bình thường (nam <0,90; nữ<0,85)	128	37,6
	±SD: 86,7±9,6cm Cao nhất: 126cm Thấp nhất: 61cm		

Nhận xét: Bệnh nhân có thời gian mắc bệnh ≥5 chiếm 57,6%, mắc kèm tăng huyết áp chiếm 77,6%, mắc kèm rối loạn lipid chiếm 66,2%, BMI >23 chiếm 67,9%, vòng eo trên ngưỡng khuyến cáo chiếm 62,4%.

Bảng 3. Một số thói quen của đối tượng nghiên cứu

Thói quen	Giá trị	n=340	Tỷ lệ %
Hoạt động thể lực	Đủ	196	57,6
	Không đủ	144	42,4
Tuân thủ chế độ ăn	Tuân thủ	185	54,4
	Không	155	45,6
Tuân thủ dùng thuốc	Tuân thủ	225	66,2
	Không	155	38,8

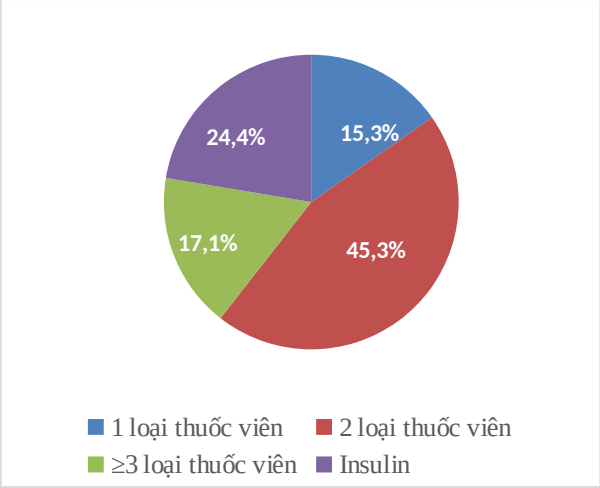
Nhận xét: Nhóm hoạt động thể lực đủ chiếm tỷ lệ 57,6%, tuân thủ chế độ ăn chiếm 54,4%, tuân thủ dùng thuốc chiếm 66,2% so với các nhóm còn lại.

3.2. Thuốc điều trị đái tháo đường típ 2

Bảng 4. Các thuốc sử dụng điều trị đái tháo đường típ 2

Nhóm thuốc	Hoạt chất	Liều trung bình	Số bệnh nhân	Tỷ lệ (%)
Biguanid	Metformin 500,850,1000mg	1781±276mg	315	92,6
Sulfonylure	Gliclazid 30,60mg	72±32mg	270	79,4
Ức chế α-glucosidase	Acarbose 50,100mg	100±28mg	57	16,8
Ức chế DPP-4	Sitagliptin 50mg	50±0mg	10	2,9
Ức chế SGLT2	Dapagliflozin 10mg	10±0mg	3	0,9
Insulin		42±16IU	76	22,4

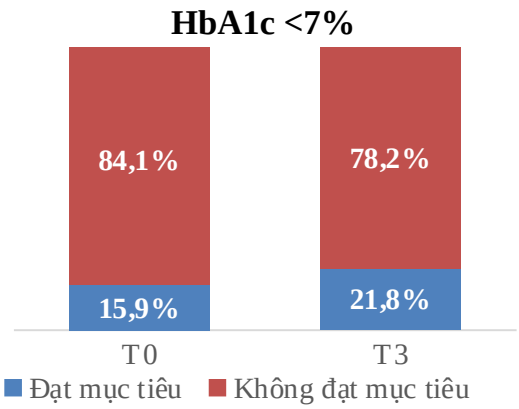
Nhận xét: Bệnh nhân được điều trị chủ yếu bằng 2 nhóm thuốc uống là biguanid và sulfonylure với liều metformin trung bình 1781±276mg và gliclazid là 72±32mg. Thấp nhất là các thuốc mới như sitagliptin chưa tới 3% và dapagliflozin chưa tới 1%.



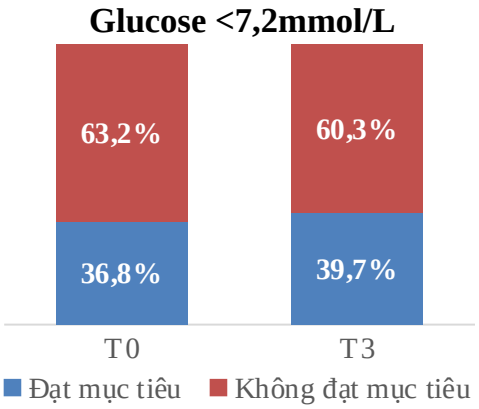
Biểu đồ 1: Tỷ lệ các phác đồ điều trị

Nhận xét: Phác đồ điều trị chủ yếu là phối hợp thuốc đường uống chiếm tỷ lệ 75,6%. Điều trị với insulin chiếm 24,4%.

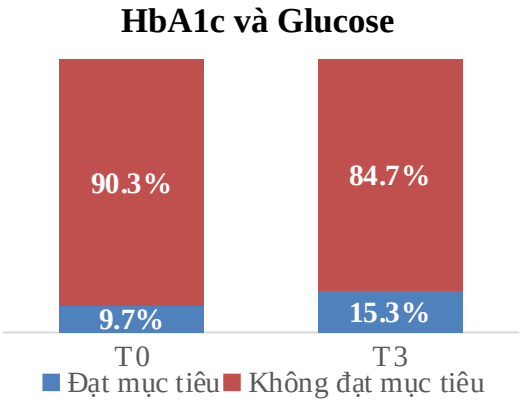
3.3. Đánh giá kết quả kiểm soát đường huyết sau 3 tháng điều trị



Biểu đồ 2: Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c ở 2 thời điểm



Biểu đồ 3: Tỷ lệ đạt mục tiêu điểm



Biểu đồ 4: Tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c và Glucose ở 2 thời điểm

Nhận xét: Sau 3 tháng điều trị, tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c tăng từ 15,9% - 21,8%, tỷ lệ đạt mục tiêu glucose đói tăng từ 36,8%-39,7%, tỷ lệ đạt cả 2 mục tiêu HbA1c và glucose đói tăng từ 9,7%-15,3%.

3.4. Một số yếu tố liên quan đến việc đạt mục tiêu HbA1c

Bảng 5. Liên quan giữa đặc điểm chung bệnh nhân đến mục tiêu HbA1c

Yếu tố		**HbA1c<7%**	**HbA1c≥7%**	**OR Cl 95%**	**p**
Nhóm tuổi	≥60	34 (22,8%)	115 (77,2%)	1,12 (0,67-1,87)	p=0,677
	<60	40 (20,9%)	151 (79,1%)		
Giới	Nam	31 (30,1%)	72 (69,9%)	**1,94** (1,14-3,32)	**p=0,014**
	Nữ	43 (18,1%)	194 (81,9%)		

Yếu tố		HbA1c<7%	HbA1c≥7%	OR Cl 95%	p
Trình độ	Trên tiểu học	39 (30,5%)	89 (69,5%)	**2,22** (1,31-3,74)	**p=0,003**
	Tiểu học-Mù chữ	35 (16,5%)	177 (83,5%)		

Nhận xét: Nam giới đạt mục tiêu HbA1c cao gấp 1,94 lần nữ giới. Bệnh nhân có trình độ trên tiểu học kiểm soát HbA1c gấp 2,22 lần bệnh nhân có trình độ tiểu học/mù chữ.

Bảng 6. Liên quan giữa đặc điểm lâm sàng bệnh nhân đến mục tiêu HbA1c

Yếu tố		HbA1c<7%	HbA1c≥7 %	OR Cl 95%	p
Thời gian mắc bệnh	<5 năm	46 (31,9%)	98 (68,1%)	**2,816** (1,66-4,79)	**p<0,001**
	≥5 năm	28 (14,3%)	168 (85,7%)		
BMI	Thừa cân/béo phì	54 (23,4%)	177 (76,6%)	1,36 (0,77-2,41)	p=0,294
	Bình thường	20 (18,3%)	89 (81,7%)		
Vòng eo	Bình thường	36 (28,1%)	92 (71,9%)	**1,79** (1,06-3,02)	**p=0,027**
	Cao	38 (17,9%)	174 (82,1%)		
Thuốc điều trị	1 loại thuốc uống	21 (28,4%)	31 (59,6%)	1	-
	2 loại thuốc uống	44 (28,6%)	110 (71,4%)	1,69 (0,88-3,26)	p=0,115
	≥3 loại thuốc uống	3 (5,2%)	55 (94,8%)	**12,42** (3,43-45,00)	**p<0,001**
	Insulin	6 (7,9%)	70 (92,1%)	**7,90** (2,91-21,50)	**p<0,001**

Nhận xét: Bệnh nhân có thời gian mắc bệnh dưới 5 năm đạt mục tiêu HbA1c cao gấp 2,82 lần trên 5 năm; có vòng eo bình thường đạt mục tiêu HbA1c gấp 1,79 lần vòng eo trên ngưỡng; được điều trị với 1 loại thuốc uống đạt mục tiêu HbA1c cao gấp 12,42 lần điều trị ≥ 3 loại thuốc uống và gấp 7,90 lần nhóm điều trị với insulin.

Bảng 7. Liên quan giữa một số thói quen bệnh nhân đến mục tiêu HbA1c

Yếu tố		HbA1c <7%	HbA1c ≥7%	OR Cl 95%	p
Hoạt động thể lực	Đủ	57 (39,6%)	87 (60,4%)	**6,90** (3,79-2,56)	**p<0,001**
	Không đủ	17 (8,7%)	179 (91,3%)		
Tuân thủ chế độ ăn	Tuân thủ	50 (27,0%)	135 (73,0%)	**2,02** (1,18-3,48)	**p=0,01**
	Không	24 (15,5%)	131 (84,5%)		
Tuân thủ dùng thuốc	Tuân thủ	60 (26,7%)	165 (73,3%)	**2,62** (1,39-4,94)	**p=0,002**
	Không	14 (12,2%)	101 (78,2%)		

Nhận xét: Bệnh nhân có HĐTL đủ đạt mục tiêu HbA1c cao gấp 6,90 lần không đủ; tuân thủ chế độ ăn đạt mục tiêu HbA1c gấp 2,02 lần không tuân thủ; tuân thủ dùng thuốc đạt mục tiêu HbA1c cao gấp 2,62 lần không tuân thủ.

Bảng 8. Hồi quy logistis các yếu tố liên quan đến đạt mục tiêu HbA1c

Yếu tố		**OR** (Cl 95%)	**p**
Vòng eo	Bình thường	**2,51** (1,43-5,46)	**p=0,020**
	Trên ngưỡng		
Trình độ	Trên tiểu học	**2,07** (1,07-4,01)	**p=0,031**
	Mù chữ, tiểu học		
Hoạt động thể lực	Đủ	**6,06** (3,04-12,09)	**p<0,001**
	Không đủ		
Thuốc điều trị	1 loại thuốc uống	-	-
	≥3 loại thuốc uống	**13,71** (3,35-56,21)	**p<0,001**
	Insulin	**5,88** (1,85-18,71)	**p=0,003**

Nhận xét: Kết quả phân tích đa biến cho thấy có 4 biến độc lập có ý nghĩa thống kê dự đoán cho việc đạt mục tiêu HbA1c: Vòng eo bình thường đạt mục tiêu cao gấp 2,51 lần trên ngưỡng. Trình độ trên tiểu học đạt mục tiêu cao gấp 2,07 lần tiểu học/mù chữ. HĐTL đủ đạt mục tiêu HbA1c gấp 6,06 lần không đủ. Điều trị với 1 thuốc uống đạt mục tiêu gấp 13,71 lần ≥3 thuốc uống và cao gấp 5,88 lần với insulin.

4. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Trong mẫu nghiên cứu, nữ giới nhiều hơn gấp hai lần nam giới. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu ở Việt Nam là tỷ lệ nữ giới mắc ĐTĐ cao hơn nam giới. Số liệu của bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2017 cho thấy trong khoảng 1,4 triệu bệnh nhân mắc ĐTĐ típ 2 trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ 59% nhiều hơn nam giới [9]. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy nam giới có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ típ 2 cao gần gấp đôi so với nữ giới. Thống kê của IDF (2021) cho thấy có 17,7 triệu nam giới nhiều hơn nữ giới đang sống chung với bệnh ĐTĐ [6].

Nhóm đối tượng có trình độ thấp gồm mù chữ, tiểu học chiếm tỷ lệ 62,4%. Bệnh viện Nhật Tân nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực này có tỷ lệ hoàn thành cấp học thấp hơn mặt bằng chung của cả nước, trình độ học vấn thấp khiến cho người bệnh không đủ kiến thức cần thiết để có thể tự chăm sóc theo khuyến cáo.

Tỷ lệ thừa cân, béo phì chiếm đa số với 67,9%. Chỉ số khối cơ thể BMI, số đo vòng eo có mối quan hệ chặt chẽ với bệnh ĐTĐ típ 2 và đề kháng insulin. Ở người thừa cân lượng acid béo tự do, glycerol, hormone, cytokine và các chất khác có liên quan đến

sự phát triển của kháng insulin đều tăng lên. Kháng insulin với sự suy giảm chức năng của tế bào β dẫn đến sự phát triển của bệnh ĐTĐ [4].

Đa số bệnh nhân ĐTĐ típ 2 trong mẫu nghiên cứu mắc kèm bệnh tăng huyết áp với 77,6% hoặc rối loạn lipid máu với 66,2% hoặc mắc kèm cả hai. Đề kháng insulin dường như là một hội chứng liên quan đến một nhóm các rối loạn chuyển hóa, bao gồm đái tháo đường típ 2, béo phì, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch. Chính vì thế việc kiểm soát huyết áp, lipid máu đường huyết ở người ĐTĐ típ 2 đã trở thành các mục tiêu quan trọng điều trị ĐTĐ típ 2, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đây là biến chứng gây tử vong cao nhất của bệnh ĐTĐ với khoảng 80% bệnh nhân chết vì bệnh tim mạch hay đột quỵ [5].

Nhìn chung, thuốc điều trị ĐTĐ tại bệnh viện Nhật Tân tương đối phong phú với 6 nhóm thuốc góp phần đa dạng hóa phác đồ điều trị phù hợp với các đối tượng bệnh khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu sử dụng phối hợp 2 thuốc giữa metformin và gliclazid với tỷ lệ 44,7%. Xét về đường dùng thì liệu pháp sử dụng thuốc đường uống chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số đơn thuốc ngoại trú 75,6%, liệu pháp sử dụng insulin chiếm tỷ lệ 24,4%. Trong mẫu nghiên cứu có 128 bệnh nhân với chỉ số HbA1c cao ≥9%, nhưng chỉ có 50 bệnh nhân được chỉ định insulin. Theo hướng dẫn nên sử dụng sớm insulin nếu mức HbA1c ≥9% hoặc mức glucose huyết rất cao ≥300 mg/dL (16,7mmol/L) [1]. Việc sử dụng sớm insulin cho các đối tượng có đường huyết cao có thể kịp thời ngăn chặn nguy cơ nhập viện và các biến chứng nguy hiểm.

4.2. Tỷ lệ đạt mục tiêu đường huyết và các yếu tố liên quan

HbA1c là xét nghiệm quan trọng đánh giá rõ nhất về kết quả điều trị ĐTĐ. Nghiên cứu cho thấy nếu HbA1c giảm được 1% làm giảm 37% các biến chứng mạch máu nhỏ, giảm 14% nhồi máu cơ tim và giảm 12% đột quỵ [7]. Sau 3 tháng điều trị tại thời điểm T3, HbA1c trung bình là 8,60±1,77%, giảm hơn so với thời điểm T0 và tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu HbA1c tăng lên 21,8%. Kết quả điều trị ĐTĐ típ 2 tại bệnh viện Nhật Tân vẫn còn tương đối thấp nếu so với số liệu từ chương trình Đánh giá ĐTĐ Liên Châu Á tại Việt Nam năm 2014 với tỷ lệ bệnh nhân có HbA1c <7% là 30% [12]. Một số nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ đạt HbA1c mục tiêu cao hơn của chúng tôi như Hứa Thành Nhân (2014) là 33,8% [2], Trần Thị Tâm (2020) với tỷ lệ 52,7% [3]. Nghiên cứu ở một số nước đang phát triển khác như Thái Lan của tác giả Janjira Jitraknatee (2020) tỷ lệ đạt mục tiêu HbA1c là 36,1% [8]. Tại Philippin, nghiên cứu của Majorie Palermo (2016) có tỷ lệ HbA1c đạt là 31,8% [11]. Dù tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu còn thấp so với các nghiên cứu khác nhưng vẫn cho thấy hiệu quả của việc điều trị bệnh ĐTĐ típ 2 và các biện pháp can thiệp tại bệnh viện.

Một số yếu tố liên quan đến kiểm soát HbA1c đạt mục tiêu và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê bao gồm: giới tính, trình độ học vấn, thời gian mắc bệnh, vòng eo, thuốc điều trị nhóm thuốc viên hoặc phối hợp insulin, hoạt động thể lực, tuân thủ chế độ ăn,

tuân thủ dùng thuốc. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê trong việc kiểm soát HbA1c đạt mục tiêu: nhóm tuổi, BMI, nhóm đối tượng điều trị 2 nhóm thuốc viên và 01 nhóm thuốc viên.

Khi phân tích hồi quy đa biến: 04 yếu tố độc lập liên quan đến kiểm soát HbA1c đạt hiệu quả bao gồm vòng eo, trình độ học vấn, hoạt động thể lực. Điều trị với 1 thuốc uống so với ≥3 thuốc và phối hợp insulin. Nghiên cứu của Hứa Thành Nhân [2] sau khi phân tích hồi quy logistic đa biến, chỉ có 4 yếu tố độc lập liên quan đến đạt mục tiêu HbA1c gồm tuổi, tuân thủ chế độ ăn, điều trị với insulin và số lượng thuốc viên hạ đường huyết. Nghiên cứu của Salam Alqudah và cộng sự [13] sau khi phân tích hồi quy tuyến tính đa biến chỉ còn 4 yếu tố liên quan đến HbA1c là tuân thủ dùng thuốc, dùng insulin, bệnh đồng mắc và thời gian mắc bệnh. Kết quả nghiên cứu của các tác giả tuy có khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, cho thấy việc kiểm soát đường huyết để đạt mục tiêu điều trị rất phức tạp do phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan. Người thầy thuốc cũng như thân bệnh nhân cần phải hiểu rõ để phối hợp điều trị một cách hiệu quả hơn.

5. KẾT LUẬN

Tuổi trung bình 58,3±10,0 năm. Nữ chiếm tỷ lệ 69,7%. Thời gian mắc bệnh trung bình 7,31±5,85 năm. Nhóm bệnh nhân mù chữ, tiểu học chiếm tỷ lệ 62,4%. Tỷ lệ thừa cân và béo phì chiếm tỷ lệ 68,1%. Tỷ lệ vòng eo trên ngưỡng khuyến cáo là 64,4%. Bệnh đồng mắc tăng huyết áp với tỷ lệ 77,6%, rối loạn lipid 66,2%. Có 6 thuốc được dùng điều trị bệnh nhân ĐTĐ típ 2, bệnh nhân điều trị chủ yếu bằng 2 thuốc uống metformin và gliclazide với tỷ lệ 92,6% và 79,4%. Phác đồ điều trị chủ yếu là phối hợp 2 thuốc viên (45,3%).

Bệnh nhân đạt mục tiêu HbA1c là 21,8%. Đạt mục tiêu glucose đói là 36,8%. Đạt cả 2 mục tiêu glucose đói và HbA1c là 15,3%.

Khi phân tích hồi quy đa biến có 4 yếu tố độc lập liên quan đến đạt mục tiêu HbA1c: bệnh nhân có vòng eo bình thường đạt MT HbA1c cao gấp 2,51 lần trên ngưỡng. Trình độ trên tiểu học đạt MT HbA1c cao gấp 2,07 lần tiểu học/MC. HĐTL đủ đạt MT HbA1c cao gấp 6,06 lần không đủ . Điều trị với 1 thuốc uống đạt MT HbA1c gấp 13,71 lần điều trị ≥3 thuốc uống và cao gấp 5,88 lần điều trị với insulin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2020), *Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2*, Ban hành kèm theo Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020.
2. Hứa Thành Nhân, Nguyễn Thy Khuê (2014), "Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đạt mục tiêu HbA1c, tại một phòng khám chuyên khoa đái tháo đường ở TP Hồ Chí Minh", *Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường*, (13), 35-40.

3. Trần Thị Tâm, Đặng Thị Ly (2020), "Nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu và các yếu tố ảnh hưởng trên bệnh nhân đái tháo đường", *Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường*, (41), 48-53.

4. Abdullah S Al-Goblan, Mohammed A Al-Alfi and Muhammad Z Khan (2014), "Mechanism linking diabetes mellitus and obesity", *Diabetes Metab Syndr Obes*, (7), 587–591
5. International Diabetes Federation (2016), *Diabetes and cardiovascular*
6. International Diabetes Federation (2021), *Diabetes Atlas 10th edition.*
7. Irene M Stratton, Amanda I Adler, H Andrew W Neil et al (2000), "Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study", *BMJ Journals*, 321(7258), 405-12.
8. Janjira Jitraknatee, Chidchanok Ruengorn , Surapon Nochaiwong (2020), "Prevalence and risk factors of chronic kidney disease among type 2 diabetes patients: a cross sectional study in primary care practice", *www.nature.com*, 10: 6205.
9. Huy Tuan Kiet Pham, Thi Tuyet Mai Kieu, Tuan Duc Duong et al, (2020), "Direct medical costs of diabetes and its complications in Vietnam: A national health insurance database study", *Diabetes Research and Clinical Practice*, 162:108051.
10. Mariusz Jaworski , Mariusz Panczyk , Małgorzata Cedro , Alicja Kucharska (2018), "Adherence to dietary recommendations in diabetes mellitus: disease acceptance as a potential mediator", *Patient Prefer Adherence*, (12), 163-174
11. Majorie Palermo, Mark Anthony Sandoval (2016), "Assessment of Physical Activity Level among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus at the UP-Philippine General Hospital Diabetes Clinic", *Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies*, 31(2), 144
12. Roseanne O Yeung, Yuying Zhang (2014), "Metabolic profiles and treatment gaps in young-onset type 2 diabetes in Asia (the JADE programme): a cross-sectionalstudy of a prospective cohort", *Lancet Diabetes Endocrinol*, (2), 935–43
13. Salam Alqudah, Anan S. Jarab, Eman A. Alefishat et al (2019), "Factors Associated with Poor Hemoglobin A1c Control in Patients with Type 2 Diabetes", *Current Diabetes Reviews*, 15(2), 164-170.
14. Nguyen Thang, Nguyen H Thao, Pham T Suol et al (2015), " Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Brief Illness Perception Questionnaire, the Beliefs About Medicines Questionnaire and the Morisky Medication Adherence Scale into Vietnamese", *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 24: 627-637.
15. World Health Organization (2006), *Global Physical Activity Questionaire (Version 2.0): Analysis Guide*.
16. World Health Organization (2008), *Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation.*

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH GÃY XƯƠNG SƯỜN TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN ỔN ĐỊNH HUYẾT ĐỘNG

Châu Hữu Hầu, Lê Trung Thi, Hoàng Thụy Đoan Trâm,
Bông Thị Trang

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Với dân số nước ta ngày càng đông, phương tiện di chuyển và quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, những chấn thương ngực dễ xảy ra do tai nạn giao thông hay do va chạm trong sinh hoạt, lao động hay nguyên nhân khác.Theo một nghiên cứu ở Iran, Chardoli ghi nhận gãy xương sườn rất phổ biến với tỷ lệ 12,5% trên phim X-quang và 25,5% trên CT-scan ở bệnh nhân chấn thương ngực kín[1].Vafaei và cs qua các nghiên cứu ở Mỹ và Canada xác định gãy xương sườn trong 10% tất cả các ca chấn thương và hơn 30% các ca chấn thương ngực nhẹ đến khoa cấp cứu [4].

Nghiên cứu này tập trung vào mục tiêu so sánh mức độ phát hiện tổn thương ở xương sườn bằng các kỹ thuật X-quang, siêu âm và CT-scan, nhằm trả lời cho câu hỏi thường được đặt ra trước các bác sĩ lâm sàng: Nên lựa chọn kỹ thuật chẩn đoán nào tốt hơn cho gãy xương sườn trước một bệnh nhân có chấn thương ngực kín?

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu*:* Tất cả các trường hợp người lớn (≥18 tuổi) bị chấn thương ngực kín, mức độ nhẹ, không có tổn thương huyết động.

Đối tượng loại trừ: Các trường hợp chấn thương ngực kín nặng có tổn thương huyết động. Các bệnh nhân cần cấp cứu do chấn thương ngực hoặc do các chấn thương nặng ở các cơ quan khác. Trẻ em. Bệnh nhân từ chối tham dự vào nghiên cứu.

2.2 Thời gian & Địa điểm*:*

Nghiên cứu được tiến hành trong 11 tháng, từ 12/2021 cho đến10/2022; tại Bệnh viện Nhật Tân, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu*:*Chọn mẫu thuận tiện. Chúng tôi chọn được 40 bn bị chấn thương ngực kín nhẹ, không có tổn thương huyết động.

2.4 Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứ, mô tả,

2.5 Cách tiến hành:

Các bệnh nhân qua phòng khám được chẩn đoán chấn thương ngực kín, mức độ nhẹ, ổn định huyết động và chuyển vào khu chẩn đoán hình ảnh để thực hiện các kỹ thuật:

- *Chụp XQ*: Dùng máy XQ kỹ thuật số DR Shimadzu 500mA, chụp lồng ngực: thẳng và chếch bên chấn thương. Dùng chế độ mAs cao để xem thương tổn xương. Một bác sĩ CKI CĐHA đọc kết quả, xác định điểm gãy, ghi kết quả.

- *Siêu âm*: Dùng máy Siemens P9 với đầu dò linear, tần số 12MHz, tiến hành siêu âm xương sườn hai bên. Một bác sĩ CKI CĐHA thực hiện siêu âm ngực, xem phần xương sườn xác định điểm gãy, ghi kết quả.
- *Chụp CT ngực*:Dùng máy Siemens 16 slice, tiến hành chụp lồng ngực, với lát cắt mỏng, mở cửa sổ nhu mô, phổi và xương; dựng hình MPR, 3D. Một ThsBs đọc kết quả, xác định điểm gãy, ghi kết quả

2.6 Xử lý thống kê

Tất cả dữ liệu đã được nhập vào và phân tích trong SPSS (phiên bản 20). Do số liệu trong nghiên cứu này là các mẫu nhỏ, so sánh từng cặp, không có phân phối chuẩn, chúng tôi dùng kiểm định phi tham số Wilcoxon Signed Ranks Test. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p <0,05.

2.7 Đạo đức trong nghiên cứu:

Các đối tượng được thông báo chi tiết về nội dung, mục tiêu nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo vệ.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Một số đặc điểm đối tượng

Tuổi của đối tượng nghiên cứu: thấp nhất 34, cao nhất 79, trung bình 51,7±11.8

Giới: Nữ chiếm 40%(16 người), nam chiếm 60% (24 người)

Nguyên nhân chấn thương ngực: Té ngã 22 (55%), tai nạn giao thông 17 (42.5%), nguyên nhân khác 1 (2.5%)

3.2 So sánh kết quả phát hiện tổn thương của 3 phương pháp

Bảng 1. ***Thống kê số xương sườn bị gãy qua X-quang, siêu âm và CT ở bệnh nhân chấn thương ngực kín ổn định huyết động***

Số TT BN	Giới	Tuổi	Lý do	Số xương sườn gãy được phát hiện			Số TT BN	Giới	Tuổi	Lý do	Số xương sườn gãy được phát hiện		
				XQ	SÂ	CT					XQ	SÂ	CT
1	0	44	1	1	2	2	21	1	40	1	1	1	1
2	0	38	2	2	2	2	22	1	40	2	2	1	1
3	0	62	2	0	1	1	23	1	62	1	2	3	3
4	0	42	2	0	0	0	24	0	48	2	0	1	1
5	1	40	1	0	2	2	25	0	69	1	1	2	2
6	1	52	2	0	1	1	26	1	45	1	4	2	4
7	1	36	1	2	1	1	27	1	40	1	2	3	3
8	0	46	2	1	1	1	28	1	41	1	1	1	1
9	1	34	2	1	1	1	29	0	54	1	1	1	1
10	0	71	1	0	2	2	30	1	49	2	2	5	5

Số TT BN	Giới	Tuổi	Lý do	Số xương sườn gãy được phát hiện			Số TT BN	Giới	Tuổi	Lý do	Số xương sườn gãy được phát hiện		
				XQ	SÂ	CT					XQ	SÂ	CT
11	0	58	1	1	1	2	31	0	52	1	1	1	1
12	1	40	2	0	0	0	32	1	39	1	1	3	3
13	1	50	1	5	4	6	33	0	65	1	0	3	3
14	1	58	1	0	3	2	34	0	58	1	0	0	0
15	1	42	2	3	2	2	35	1	53	2	1	2	2
16	0	42	3	0	0	0	36	0	69	1	0	5	5
17	1	59	2	2	2	2	37	1	57	2	3	5	5
18	1	60	1	1	2	2	38	0	36	2	1	4	6
19	1	79	1	1	3	3	39	1	66	2	3	4	6
20	1	65	1	1	1	1	40	1	67	2	2	4	4

Ghi chú: Giới: nữ=0, nam=1; Lý do: 1=té, 2=tai nạn giao thông, 3=tai nạn giao thông và té ngả

Bảng 2. ***So sánh tỷ lệ chẩn đoán đúng của 3 phương pháp***

Kỹ thuật chẩn đoán	Số xương sườn gãy được phát hiện				Độ lệch chuẩn	So với CT (%)
	Tối thiểu	Tối đa	Tổng số	Trung bình		
X-quang	0	5	49	1, 225	1, 187	54,4
Siêu âm	0	6	84	2.100	1,549	93,3
CT	0	6	90	2,250	1,706	100

Bảng 3. ***So sánh tỷ lệ chẩn đoán đúng của siêu âm và X-quang(bằng Wilcoxon Signed Ranks Test)***

Chỉ số khảo sát	Siêu âm và X-quang			CT và X-quang			CT và siêu âm		
	N	Mean Rank	Sum of Ranks	N	Mean Rank	Sum of Ranks	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Hiệu số âm	20	12.43	248.5	23	14.28	328.50	7	5.14	36.00
Hiệu số dương	3	9.17	27.50	3	7.50	22.50	2	4.05	9.00
Số ca giống nhau	17			14			31		
Lệch chuẩn Z, p	-3.422, p<0,001			-3.969, p=0.001			-1.732, p=0.083		

BÀN LUẬN

- ***Vai trò của CT-scan trong chẩn đoán gẫy xương sườn***

Theo Simon, chụp CT là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán gãy xương sườn [2]. Tuy nhiên có nhiều nghiên cứu cho thấy CT-scan gãy xương sườn lần đầu cũng có thể bỏ sót một tỷ lệ khá cao. Theo Turk và cs [8] tỷ lệ bỏ sót gãy xương sườn qua CT lần đầu là 20,7%, khá cao so với CT phát hiện các đốt sống ngực hoặc xương ức (độ nhạy đạt 100%).

- ***So sánh kết quả siêu âm và X-quang.***

Khi so sánh giữa siêu âm và X-quang, cả 2 phương thức chẩn đoán đúng số ca gãy xương bằng nhau ở 14 bệnh nhân, trong khi siêu âm có số ca chẩn đoán gãy xương nhiều hơn X-quang là 20 và ít hơn 3 trên X-quang ($p<0,01$), cho thấy siêu âm nhạy hơn X-quang trong chẩn đoán gãy xương sườn ở bệnh nhân chấn thương ngực kín.

Theo nghiên cứu của Hwang và cs [6] gãy xương sườn được phát hiện trên X- quang ở 69 bệnh nhân (34,3%) nhưng không phát hiện ở 132 bệnh nhân khác, như vậy tỷ lệ bỏ sót ca bệnh nhờ X-quang là khá cao. Trong khi đó chẩn đoán gãy xương sườn bằng siêu âm lại phát hiện đến 84,6% số bệnh nhân trên. Trong số 132 bệnh nhân không được phát hiện gãy xương sườn trên X quang, có tới 92 có gãy xương sườn qua siêu âm, chiếm 69.7%. Còn trong số 69 bệnh nhân gãy xương sườn được phát hiện trên X-quang, có 33 bệnh nhân có kết quả trùng khớp với siêu âm. Như vậy rõ ràng việc dùng siêu âm vùng ngực có hiệu quả hơn X-quang khi phát hiện gãy xương sườn trong chấn thương kín vùng ngực.

- ***So sánh kết quả chụp CT và X-quang***

Khi so sánh giữa CT-scan và X-quang, ta thấy số ca CT hơn Xq là 23, số ca giống nhau 14, khác biệt với $p<0,001$ có ý nghĩa thống kê. Như vậy kết quả quét CT đạt tỷ lệ phát hiện đúng cao hơn hẳn so với chụp X-quang lồng ngực. Trong trường hợp này, theo chúng tôi nếu không có điều kiện chụp CT hay làm thêm kỹ thuật chẩn đoán khác mà vẫn muốn tăng độ chính xác của Xq ngực, ta có thể tiến hành X-quang ngực lần 2 với hy vọng cho chẩn đoán chính xác cao hơn.

- ***So sánh kết quả quả chụp CT và siêu âm***

Khi so sánh dùng CT và siêu âm thì thấy chẩn đoán gãy xương sườn giống nhau khá cao 31 trường hợp, số ca nhiều hơn siêu âm là 7, số ca ít hơn siêu âm là 2, khác biệt không có ý nghĩa thống kê với $p >0,05$. Điều này cho thấy siêu âm chẩn đoán gãy xương sườn có kết quả tuy có phần thấp hơn, nhưng đạt gần như tương đương với CT-scan.

Khi bênh nhân đến khám vì chấn thương ngực, vẫn có thể chụp X-quang ngực thẳng và chếch, nhưng muốn chính xác hơn, không bỏ sót, nhất là khi bệnh nhân còn đau dai dẳng nơi tổn thương, nên chỉ định thêm siêu âm hoặc CT nếu có điều kiện.

Kết quả khảo sát của chúng tôi trên một số lượng còn nhỏ nên rất cần có những nghiên cứu có quy mô lớn hơn, và trên những đối tượng có độ tổn thương lồng ngực ở mức cao hơn, ngay cả khi có biến đổi về huyết động. Ngoài ra do mỗi phương pháp chẩn đoán đều có những ưu, nhược điểm riêng, việc trả lời câu hỏi nên sử dụng phương pháp, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nào đối với chấn thương lồng ngực mức độ nhẹ không có biến đổi huyết động là tùy do hoàn cảnh thực tế của cơ sở bệnh viện, nhân lực thực hiện và trang thiết bị chẩn đoán, cũng như khả năng hợp tác, chi trả của người bệnh.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu trên 40 bệnh nhân chấn thương ngực kín mức độ nhẹ không có biến đổi huyết động cho thấy kỹ thuật CT-scan có tỷ lệ phát hiện gãy xương sườn cao nhất, trong khi siêu âm lồng ngực đạt kết quả 93,3% và X-quang lần 1 chỉ đạt 54,4% so với kết quả chụp CT. Mức độ phát hiện tổn thương của siêu âm có phần thấp hơn so với CT-scan tuy nhiên sự khác biệt không đáng kể. Có thể sử dụng đơn thuần hay kết hợp cả 3 kỹ thuật với nhau, tùy vào thực tế và điều kiện cụ thể của bệnh viện và bệnh nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Chardoli M, Ghaliaee TH, Akbari H, Movaghar VR.** Accuracy of chest radiography versus chest computed tomography in hemodynamically stable patients with blunt chest trauma. Chinese Journal of Traumatology 2013;16(6):351-354.

2. **Simon E.**Blunt chest trauma: who needs computed tomography imaging? emdocs. jun 26th, 2017. http://www.emdocs.net/blunt-chest-trauma-needs-computed-tomography-imaging/

3. **Morley E, Johnson W, Leibner E, Shahid J.** Emergency department evaluation and management of blunt chest and lung trauma (Trauma CME). Emerg Med Pract. 2016; 18(6):1-20.

4. Vafaei A, Hatamabadi HR, Heidary K, Alimohammadi H, Tarbiyat M.**Diagnostic Accuracy of Ultrasonography and Radiography in Initial Evaluation of Chest Trauma Patients. Emergency (2016); 4 (1):29-33**

5. Watson TS. The benefits and limitations of ultrasound in the diagnosis of rib fractures from the emergency department to the sports field: A narrative review. BCMJ, vol. 63, No.2, March 2021: 75-78.

6. **Hwang EG, Lee YJ.** Simple X-ray versus ultrasonography examination in blunt chest trauma: effective tools of accurate diagnosis and considerations for rib fractures. Journal of Exercise Rehabilitation 2016;12(6):637-641.

7. **Zhou QQ, Wang JW, Tang W, Hu ZC, Xia ZY, Li XS, Zhang R, Yin X, Zhang B, Zhang H.** Automatic Detection and Classification of Rib Fractures on Thoracic CT Using Convolutional Neural Network: Accuracy and Feasibility. Korean J Radiol. 2020 Jul;21(7):869-879.

8. **Turk F, Kurt AB, Saglam S.** Evaluation by ultrasound of traumatic rib fractures missed by radiography. Emerg Radiol 2010;17:473-477.

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH VÕNG MẠC DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN NHẬT TÂN

Trương Hoàng Nam

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ và mức độ bệnh võng mạc (BVM) do đái tháo đường (ĐTĐ) trên nhóm bệnh nhân đang điều trị ĐTĐ đến khám mắt, để có kế hoạch điều trị phối hợp lâu dài. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu**: Nghiên cứu tiến cứu và mô tả cắt ngang. **Kết quả nghiên cứu**: Nghiên cứu 139 bệnh nhân mắc ĐTĐ đến khám tại khoa mắt bệnh viện Nhật Tân: So 2 nhóm tuổi 41-59 và 60-80 mắc ĐTĐ xác định bằng HbA1c thì thấy lứa tuổi 41-59 có nồng độ HbA1c cao hơn lứa tuổi 60-80, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,030. Phân tích tình trạng BVMĐTĐ với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc bệnh thì thấy tuổi và số năm mắc bệnh ĐTĐ liên quan đến mức độ nặng của BVMĐTĐ, có ý nghĩa thống kê với p=0,007 và p=0,001; Trong khi đó đường huyết và HbA1c không liên quan đến BVMĐTĐ, p >0,05. Tỷ lệ mắc BVMĐTĐ theo kết quả khám đáy mắt chúng tôi là 34,9%, trong đó chưa tăng sinh 22,7%, tăng sinh 12,2%. Kết quả chụp OCT phát hiện 25 ca phù hoàng điểm, trong đó có 16 ca bị phù 1 mắt và 9 ca phù cả 2 mắt. **Kết luận:** Tổng số mắt phù hoàng điểm là 34/260 mắt được khám, chiếm 13,1%. Các bệnh nhân phù hoàng điểm sẽ được chỉ định điều trị sớm tiêm nội nhãn chất anti-VEGF để tránh hậu quả dẫn đến mù lòa. Ngoài ra trong nhóm BVMĐTĐ tăng sinh còn nhiều bệnh nhân (12%) còn cần phải điều trị chuyên sâu hơn.

Từ khóa: Bệnh võng mạc đái tháo đường (BVMĐTĐ), chụp cắt lớp quang học (OCT)

STUDY ON SOME CHARACTERISTICS OF DIABETIC RETINOPATHY AT THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT OF NHAT TAN HOSPITAL.

Objectives: To investigate the prevalence and severity of diabetic retinopathy in a group of patients undergoing treatment for diabetes who come to an eye examination for a long-term combination treatment plan. **Subjects and research methods**: A prospective and descriptive cross-sectional study. **Results**: A study on 139 diabetic patients who visited the Opthalmology department of Nhat Tan hospital: Compared with 2 age groups 41-59 and 60-80 with diabetes determined by HbA1c, it was found that the age group 41-59 had higher HbA1c levels than the age group 60-80, the difference was statistically significant with p =0,003. Analysis of diabetic retinopathy (DR) status with age, blood sugar, HbA1c and number of years of disease showed that age and number of years with diabetes related to the severity of DR, statistically significant with p=0.007 and p=0.001; Meanwhile, blood sugar and HbA1c were not related to DR, p >0.05. The prevalence of DR according to the results of our fundus examination was 34.9%, of which there was nonproliferative diabetic retinopathy 22.7%, proliferative diabetic retinopathy is 12.2%. OCT scan results detected 25 cases

of macular edema, including 16 cases of edema in one eye and 9 cases of edema in both eyes. **Conclusion**: Total number of eyes with diabetic macular edema was 34/260 eyes examined, accounting for 13.1%. Patients with macular edema will be prescribed early treatment with intraocular injection of anti-VEGF to avoid consequences leading to blindness. In addition, in the proliferative DR group, many patients (12%) still need more intensive treatment.

Key words: Diabetic retinopathy (DR), Optical Coherence Tomography (OCT)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) đang gia tăng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Biến chứng của bệnh rối loạn chuyển hóa Glucid này là biến chứng đa phủ tạng. Trong đó biến chứng tại mắt gây bệnh cảnh chung là giảm thị lực. Biến chứng vi mạch của (BVMĐTĐ) có thể dẫn đến mù lòa, bệnh nhân ĐTĐ có tỉ lệ mù cao hơn 20-30% so với người cùng lứa tuổi và giới mà không bị ĐTĐ [1]

Việc phát hiện sớm và điều trị sớm BVMĐTĐ sẽ làm chậm lại quá trình suy giảm thị lực, giúp người bệnh giữ được thị lực để đảm bảo một phần chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng chăm sóc người mù của bản thân bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Theo Theo tổ chức ĐTĐ thế giới có 425 triệu người trong lứa tuổi từ 20 -79 bị bệnh ĐTĐ vào năm 2017 và sẽ tăng lên 629 triệu người vào giữa thế kỷ này [6]. Báo cáo của WHO tỷ lệ bệnh VMĐTĐ chiếm từ 20% đến 40% người bị ĐTĐ tùy theo từng quốc gia và khu vực. Thời gian mắc bệnh ĐTĐ và kiểm soát đường huyết là yếu tố chính của diễn tiến BVMĐTĐ. ĐTĐ type 1 sau 5 năm 25% bệnh nhân có bệnh VMĐTĐ, sau 10 năm là 60%. ĐTĐ type 2 sau 5 năm là 40% có BVMĐTĐ và 2% có BVMĐTĐ tăng sinh.[3]

Tổn thương BVMĐTĐ chia làm 2 nhóm: chưa tăng sinh và tăng sinh [2]:

- ***BVMĐTĐ chưa tăng sinh***: mức độ nhẹ chỉ có các vi phình mạch, BVMĐTĐ chưa tăng sinh trung bình có thể có vết dạng bông và tĩnh mạch hình chuỗi hạt, BVMĐTĐ chưa tăng sinh nặng có thể xuất huyết võng mạc lan tỏa, tĩnh mạch hình chuỗi hạt hoặc dị thường vi mạch.
- ***BVMĐTĐ tăng sinh:*** có tân mạch tại võng mạc hoặc nhiều nơi khác như mống mắt, góc tiền phòng, đĩa thị và hoặc xuất huyết dịch kính, trước võng mạc, tăng sinh xơ hoặc bong võng mạc co kéo.

Khái niệm đái tháo đường bất đối xứng được định nghĩa là 1 mắt bị BVMĐTĐ tăng sinh, mắt kia không bị BVMĐTĐ, chưa tăng sinh hoặc tăng sinh nhẹ, tình trạng này kéo dài trong 2 năm. ĐTĐ bất đối xứng chiếm 5-10% bệnh nhân bị BVMĐTĐ [8].

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ và mức độ BVMĐTĐ trên nhóm bệnh nhân đang điều trị ĐTĐ đến khám mắt, để có kế hoạch điều trị phối hợp lâu dài.*

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả những bệnh nhân có bệnh ĐTĐ đã được chẩn đoán xác định tại các bệnh viện hoặc phòng khám nội và đang điều trị bệnh ĐTĐ nội hoặc ngoại trú, đến khám mắt tại khoa mắt BV Nhật Tân từ tháng 8 đến tháng 11/2022. Tất cả bệnh nhân này đều đã có sẵn kết quả xét nghiệm đường huyết và HbA1C. Khi đến khám bệnh lý tại mắt chúng tôi làm thêm các thăm dò khác như chụp OCT và soi đáy mắt để đánh giá BVMĐTĐ. Đối tượng loại trừ: bệnh nhân không hợp tác và những mắt không thể khám soi đáy mắt hoặc khảo sát OCT hay chụp võng mạc được 2 mắt do những bệnh như sẹo giác mạc, đục thủy tinh thể quá chín, đục bao sau nhiều....

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu và mô tả cắt ngang. Lấy mẫu trong thời gian nghiên cứu được 139 bệnh nhân với 227 mắt được soi đáy mắt và 260 mắt được chụp OCT đủ dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng để đưa vào nghiên cứu.

Phương tiện nghiên cứu: bảng thị lực Logmax, đèn khe khám mắt Zeizz, kính Vold, đèn soi đáy mắt trực tiếp, máy OCT(Optical coherence tomography): MOPTIM Mocean 4000, máy chụp hình đáy mắt Topcon TRC-NW8F, máy đo khúc xạ tự động Shin-Nippon , nhãn áp kế Schiote, thuốc nhỏ giãn đồng tử.

Xử lý số liệu: Dùng phần mềm thống kê SPSS 2.0, 2020. Dùng One-way ANOVA để so sánh 2 số trung bình. Trị số trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD). Trị số $p<0,05$ được xem có ý nghĩa thống kê.

Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được báo về nội dung, mục tiêu nghiên cứu. Mọi quyền lợi của người bệnh và thông tin cá nhân đều được bảo vệ.

III. KẾT QUẢ:

Bảng 1. ***Bệnh võng mạc do ĐTĐ theo giới và chỉ định can thiệp theo địa phương***

STT	**Địa phương**			**Giới tính**	
	Tên huyện	***Số ca***	***Tỷ lệ %***	***Nữ***	***Nam***
1	Châu Đốc	26	18.7	23	3
2	Tân Châu	20	14.4	16	4
3	An Phú	33	23.7	27	6
4	Châu Phú	22	15.8	20	2
5	Phú Tân	13	9.4	9	4
6	Tịnh Biên	14	10.1	9	5
7	Nơi khác	11	7.9	7	4
Cộng		**139**	**100.0**	**111 (79,8%)**	**28 (20,2%)**

Nhận xét: Tất cả các bệnh nhân bệnh võng mạch do ĐTĐ đa số ở các huyện lân cận

TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chỉ có 11 bệnh nhân ở các tỉnh khác và bệnh nhân Kampuchia. Giới nữ chiếm đa số với 79,8%.

Bảng 2. ***So sánh lứa tuổi 41-59 và 60-80 mắc ĐTĐ với HbA1c***

Lứa tuổi	n	HbA1c	Tối thiểu	Tối đa	F	p
40-59	46	9.95 ± 2.49	5.18	17.06	4.822	0.030
60-80	93	9.01 ± 2.31	5.94	17.35		
Cộng	139	9,32 ± 2.41	5.18	17.35		

Nhận xét: So sánh giữa 2 lứa tuổi 41-59 và 60-80 mắc ĐTĐ với HbA1c thì thấy lứa tuổi 40-59 có nồng độ HbA1c cao hơn lứa tuổi 60-80, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,030.

Bảng 3. ***Soi đáy mắt phải (25 mắt [18%] không được do đục thủy tinh thể, còn 114)***

Tình trạng mắt phải			**Tuổi trung bình ± SD**	**Đường huyết ± SD**	**HbA1c ± SD**	**Số năm ĐTĐ ± SD**
	N	Tlệ%				
Bình thường	68	48,9	60,4 ± 8,3	173,6 ± 75,8	9,1 ± 2,4	4,3 ± 3,5
Bệnh lý	46	33,1	64,9 ± 8,9	185,3 ± 79,7	9,4 ± 2,3	12,3 ± 5,3
Tổng cộng	114	82,0	62,2 ± 8,7	178,3 ±77,3	9,2 ± 2,4	7,5 ± 5,8
F			7.681	0.620	0.521	93.7
p			0.007	0.433	0.472	0,001

Nhận xét: Có 25 mắt phải bị đục thủy tinh thể nên không soi đáy mắt được, chỉ còn 114 mắt bên phải được soi đáy mắt. Trong số này có 46 mắt có bệnh, chiếm tỷ lệ 33,1%. Phân tích tình trạng bệnh mắt phải với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc ĐTĐ thì thấy tuổi và số năm mắc bệnh ĐTĐ có ý nghĩa thống kê với p=0,007 và p=0,001. Trong khi đó đường huyết và HbA1c không liên quan đến bệnh võng mạc mắt phải, p >0,05.

Bảng 4. ***Soi đáy mắt trái (26 mắt [18,7%] không được do đục thủy tinh thể, còn 113)***

Tình trạng mắt trái			**Tuổi trung bình ± SD**	**Đường huyết ± SD**	**HbA1c ± SD**	**Số năm ĐTĐ ± SD**
	N	Tlệ%				
Bình thường	62	44,6	62,1 ± 8,3	167,0± 71,0	9,0 ± 2,4	3,9 ± 2,9
Bệnh lý	51	36,7	63,9 ± 8,4	193,9± 88,8	9,5 ± 2,5	11,2 ± 2,5
Tổng cộng	113	81,3	62,9 ± 8,4	80,3 ± 7,6	9,2 ± 2,4	5,6 ± 0,5
F			1,360	3,210	1,405	81,8
p			0,246	0,076	0,238	0,001

Nhận xét: Có 26 mắt trái bị đục thủy tinh thể nên không soi đáy mắt được, chỉ còn 113 mắt bên trái được soi đáy mắt. Trong số này có 51 mắt có bệnh, chiếm tỷ lệ 36,7%. Phân tích tình trạng bệnh mắt trái với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc ĐTĐ thì thấy số năm mắc bệnh ĐTĐ có ý nghĩa thống kê với p=0,001. Trong khi

đó tuổi, đường huyết và HbA1c không liên quan đến mức độ nặng của BVMĐTĐ mắt trái, p >0,05.

Bảng 5. ***OCT mắt phải (9 ca [6,5%] không chụp OCT được do đục thủy tinh thể, còn lại 130)***

OCT mắt phải			**Tuổi trung bình ± SD**	**Đường huyết ± SD**	**HbA1c ± SD**	**Số năm ĐTĐ ± SD**
	N	Tlệ%				
Bình thường	89	69.5	62,2 ± 8,8	182,9 ± 79,1	9,2 ± 2,3	7,1 ± 5,9
Bệnh lý	41	31,5	62,1 ± 7,7	165,8 ± 67,7	9,4 ± 2,7	7,9 ± 5,9
Tổng cộng	130	100	62,2 ± 8,5	177,5 ± 75,8	9,3 ± 2,4	7,4 ± 5,7
F			0,005	1,445	0,127	0,510
p			0,942	0,232	0,722	0.476

Nhận xét: Trong tổng số 130 mắt bên phải có 41 mắt bị BVMĐTĐ, chiếm tỷ lệ 31,5%.

Bảng 6. ***OCT mắt trái (9 ca [6,5%] không OCT được do đục thủy tinh thể, còn lại 130)***

OCT mắt trái			**Tuổi trung bình ± SD**	**Đường huyết ± SD**	**HbA1c ± SD**	**Số năm ĐTĐ ± SD**
	N	Tlệ%				
Bình thường	90	69,2	62,3 ± 8,4	172,1 ± 68,9	9,1 ± 2,3	6,5 ±5,5
Bệnh lý	40	30,8	63,3 ± 8,0	198,4 ± 94,8	9,8 ± 2,8	9,4 ± 6,2
Tổng cộng	130		62,6 ± 8,3	180,2 ± 78,4	9,3 ± 2,5	9,3 ± 2,5
F			0,469	3,158	2,034	7,094
p			0,495	0,078	0,156	0.009

Nhận xét: Trong tổng số 130 mắt trái được chụp OCT có 40 mắt bị BVMĐTĐ, chiếm tỷ lệ 30,7%. Trong số bệnh lý này liên quan rõ với số năm mắc bệnh ĐTĐ có ý nghĩa thống kê P= 0,009

Bảng 7: ***Số mắt bị BVMĐTĐ chưa tăng sinh và tăng sinh phát hiện qua soi đáy mắt.***

Tình trạng mắt	**Số mắt phải**	Tỷ lệ %	**Số mắt trái**	Tỷ lệ %	**Cộng**	Tỷ lệ chung
Bình thường, không đo được	**93**	66,9%	**88**	63,3%	**181**	65,1%
BVM không tăng sinh	**27**	19,4%	**36**	25,9%	**63**	22,7%
BVM tăng sinh	**19**	13,7%	**15**	10,8%	**34**	12,2%
Cộng	**139**	100%	**139**	100%	**278**	100%

Nhận xét: Tỷ lệ BVMĐTĐ chưa tăng sinh là 22,7%, tăng sinh là 12,2%.

Bảng 8: ***Số mắt phù hoàng điểm phát hiện bằng máy chụp OCT***

Tình trạng bệnh võng mạc	Số mắt	Tỷ lệ %	Tỷ lệ cộng dồn
Bình thường	114	82,0	82,0
Phù hoàng điểm 1 mắt	16	11,5	93,5
Phù hoàng điểm 2 mắt	9	6,6	100,0
Cộng	139	100,0	

Nhận xét: Trong 25 ca phù hoàng điểm có 16 ca phù 1 mắt và 9 ca phù 2 mắt. Đối chiếu với bảng 5&6 có 34 mắt bị phù hoàng điểm/ 260 mắt chụp được OCT chiếm tỷ lệ 13,1%.

IV. BÀN LUẬN

1. Nhận định giữa 2 lứa tuổi 40-59 và 60-80 mắc ĐTĐ với HbA1c thì thấy lứa tuổi 41-59 có nồng độ HbA1c cao hơn lứa tuổi 60-80, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,030. Điều này có thể lý giải người cao tuổi điều trị, dự phòng, thể dục, ăn kiêng giảm cân tốt hơn.

2. Soi đáy mắt bên phải phát hiện 33,1% mắt bị bệnh. Phân tích tình trạng bệnh mắt phải với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc ĐTĐ thì thấy tuổi và số năm mắc bệnh ĐTĐ có ý nghĩa thống kê với p=0,007 và p=0,001. Trong khi đó đường huyết và HbA1c không liên quan đến bệnh võng mạc mắt phải, p >0,05. Điều này có lẽ do số bệnh nhân trẻ việc tuân thủ điều trị kém nên đường huyết và HbA1c còn tăng cao nhưng chưa có thời gian đủ lâu để làm tổn thương bệnh VMĐTĐ. Điều này cũng tương tự nhận định tham khảo của nghiên cứu ở bệnh viện tỉnh Tiền Giang (3)

3.Trong số 51 mắt bên trái có bệnh, chiếm tỷ lệ 36,7%. Phân tích tình trạng bệnh mắt trái với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc ĐTĐ thì thấy số năm mắc bệnh ĐTĐ có ý nghĩa thống kê với p=0,001. Trong khi đó tuổi, đường huyết và HbA1c không liên quan đến mức độ nặng của BVMĐTĐ mắt phải, p >0,05. Như vậy trong khảo sát của chúng tôi ở cả 2 mắt thì thời gian mắc bệnh vẫn liên quan chính với tổn thương BVMĐTĐ.

4.Về tỷ lệ mắc BVMĐTĐ theo kết quả soi đáy mắt ở 2 mắt trung bình là là 34,9%: MP có bệnh là 46/227 mắt, chiếm 33,1%. MT là 51/ 227 mắt, chiếm 36,7%. Tỷ lệ này thấp hơn khảo sát ở bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng là 50,9% [4]. Về kết quả chụp OCT, số mắt bị bệnh trung bình ở 2 mắt là 31,1%: MP là 41(31,5%). MT là 40 (30,8%). Tỷ lệ này thấp hơn khảo ở bệnh viện nội tiết trung ương là 45,8% [5]. Chúng tôi nhận định 2 phương pháp khám soi đáy mắt và chụp OCTđều phát hiện số BVMĐTĐ thấp hơn đơn vị bạn, có lẽ do bệnh nhân ở đây chủ yếu đi khám mắt chứ không phải khu điều trị BVMĐTĐ như những đơn vị trên, nên số bệnh nhân bị bệnh VMĐTĐ có tỷ lệ thấp hơn. Trong khi đó ở bệnh viện tỉnh Tiền Giang tỷ lệ BVMĐTĐ

chỉ chiếm 23,4%[3] trong số bệnh nhân ĐTĐ, còn thấp hơn nữa trong nghiên cứu của chúng tôi.

5. Đánh giá mức độ tổn thương chung của BVMĐTĐ qua soi đáy mắt tổng là 34,9%: Với phân loại chưa tăng sinh 22,7%, tăng sinh 12,2%. Tỷ lệ này cũng thấp hơn một ít so với nghiên cứu ở Thái Nguyên tỷ lệ chung là 37% [9] và thấp hơn nhiều ở Hải Phòng chưa tăng sinh là 28,7%, tăng sinh là 22,2%. [4].

6. Tỷ lệ mắc bệnh và mức độ trầm trọng của 2 mắt vẫn khác nhau trên cùng 1 bệnh nhân. Điều này cho thấy khái niệm BVMĐTĐ không đối xứng ở 2 mắt, vì nhiều lý do cùng tồn tại trên 2 mắt khác nhau như nhãn áp, bệnh mạch máu, màng bồ đào …[8]. Trong nghiên cứu này đã cho thấy sự không tương xứng của BVMĐTĐ qua chụp OCT và soi đáy mắt ở 2 mắt. Tuy nhiên chúng tôi chưa đi sâu nghiên cứu này vì định nghĩa sự bất đối xứng của 2 mắt phải kéo dài trong 2 năm. (8)

7. Nhận định tổn thương phù hoàng điểm qua chụp OCT: Trong số 25 ca bị phù hoàng điểm có 16 ca bị phù 1 mắt và 9 ca phù 2 mắt. Tỷ lệ số mắt phù hoàng điểm là 13,1% (34/260 mắt). Tỷ lệ này cũng tương đương so với nghiên cứu ở bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng là 10,2% [4] và thấp hơn so với nghiên cứu ở Đà Nẵng là 20% [7]. Số 34 mắt phù hoàng điểm này là có chỉ định tiêm nội nhãn điều trị BVMĐTĐ, việc chỉ định tiêm sớm chất anti VEGF (Vascular endothelial growth factor) là rất cần thiết để tránh hậu quả dẫn đến mù lòa. Ngoài ra trong nhóm BVMĐTĐ tăng sinh có 1 số chỉ định can thiệp điều trị nội ngoại khoa hoặc Laser quang đông kết hợp nữa chúng tôi sẽ đề cập trong 1 nghiên cứu khác. Đây cũng là mục tiêu khảo sát chính của chúng tôi để triển khai điều trị phối hợp tại bệnh viện này trong năm 2023 và những năm sau.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu 139 bệnh nhân mắc ĐTĐ đến khám tại khoa mắt bệnh viện Nhật Tân: So bệnh nhân 2 nhóm tuổi mắc ĐTĐ xác định bằng HbA1c thì thấy lứa tuổi 41-59 có nồng độ HbA1c cao hơn lứa tuổi 60-80, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,030. Phân tích tình trạng BVMĐTĐ với tuổi, đường huyết, HbA1c và số năm mắc bệnh thì thấy tuổi và số năm mắc bệnh ĐTĐ liên quan đến mức độ nặng của BVMĐTĐ, có ý nghĩa thống kê với p=0,007 và p=0,001. Trong khi đó đường huyết và HbA1c không liên quan đến BVMĐTĐ, p >0,05. Tỷ lệ mắc BVMĐTĐ theo kết quả khám đáy mắt là 34,9%, trong đó chưa tăng sinh 22,7%, tăng sinh 12,2%. Kết quả OCT phát hiện 25 ca phù hoàng điểm, trong đó có 16 ca bị phù 1 mắt và 9 ca phù cả 2 mắt. **Kết luận:** Tổng số mắt phù hoàng điểm là 34/260 mắt được khám, chiếm 13,1%. Các bệnh nhân phù hoàng điểm sẽ được chỉ định điều trị sớm bằng cách tiêm nội nhãn chất anti-VEGF để tránh hậu quả dẫn đến mù lòa. Ngoài ra trong nhóm BVMĐTĐ tăng sinh còn nhiều bệnh nhân (12%) cần phải điều trị chuyên sâu hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Lan Anh KT, Kim Anh DT, Linh PV**: Đặc điểm Lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng mắt trên bệnh nhân ĐTĐ típ 2. Tạp chí Y học Việt Nam tháng 6- 2022.
2. **Nika Bagheri, Brynn N. Wajda**. Cẩm nang nhãn khoa lâm sàng, Nhà xuất bản y học 2017.
3. **Chi CM, Minh Khương NT, Hoa Vân TT**. Nghiên cứu biến chứng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Nội tiết và ĐTĐ số 46- 2021.
4. **Lan Anh LT, Kim Anh ĐT, Linh PV**. Đặc điểm Lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng mắt trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị tại khoa nội 3. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Tạp chí Y học Việt Nam tập 515, tháng 6, số đặc biệt 2022.
5. **Hiền NB, Đệ ĐV, Đàm NV.** Khảo sát tỉ lệ một số biểu hiện tổn thương mắt ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2. Bệnh viện nội tiết Trung ương, Vietnam Medical Journal. N2 June - 2022.
6. **Sha W, Wen S, Chen L, Xu B, Lei T, Zhou L**. " The Role of SGLT2 Inhibitor on the treatement of Diabetic Retinopathy" Journal of Diabetes Research, Volume 2020. Article ID 8867875, 6 pages.
7. **Kim Yến NT, Hoài Vi TT, Quảng Trị NT, Thanh NN, Tuấn NM**. Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đườngở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường số 49 năm 2021.
8. **Azad R, Sinha S, Nishant P**. Asymmetric diabetic retinopathy. Indian Journal of Ophthalmology.
9. **Hải Hà LT, Minh ĐĐ, Hoa NT**. Liên quan giữa nồng độ lipid huyết tương với tổn thương bệnh võng mạc đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên. Hội nghị khoa học lần thứ XXIV của hội hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG STEVEN JOHSON

Châu Hữu Hầu, Nguyễn Văn Đồng
Trần Thị Thúy Phụng, Quách Thiện Tiền

I. TỔNG QUAN

Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) là những phản ứng niêm mạc hay ở da có thể gây ra một cấp cứu y tế và nghiêm trọng hơn là đe doạ tính mạng, nguyên nhân chủ yếu là do thuốc. Tỷ lệ tử vong đối với SJS và TEN cao tới 30% và có thể gây ra các bệnh ngắn hạn hoặc dài hạn. Do đó việc nhận biết sớm và xử lý nhanh chóng có thể cứu sống bệnh nhân[(1)]. Bệnh tương đối hiếm gặp, tỉ lệ mắc khoảng 0,4-1,3 trường hợp/1.000.000 dân/năm. Tại bệnh viện Da liễu trung ương từ năm 2007-2010, TEN chiếm 1,15% tổng số người dị ứng thuốc. Bênh gặp ở nhiều lứa tuổi, tuổi càng lớn thì tỷ lệ mắc càng cao.

Bài báo này xin trình bày một ca lâm sàng mắc hội chứng Steven Johnson điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nhật Tân.

II. THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ và tên: SANH TH. **Giới:** Nam **Tuổi:** 59

Địa chỉ: Bét Chại - Cỏ Thum – Kandal **MSBN:** 2200300956

Nhập viện: ngày 14/11/2022

Bệnh sử: Bệnh nhân khai cách nhập viện 7 ngày, bệnh đau nhức cơ thể mua thuốc tiệm thuốc tây uống gồm Piroxicam, Ampicillin, Betamethason 0,5mg, Paracetamol, uống đến ngày thứ 5 bệnh nhân sốt, chích thuốc Bác sĩ tư thì sốt giảm, sau đó sốt lại kèm đau họng, được kê thuốc uống và rơ lưỡi, đến ngày thứ 7 thì bệnh ngứa vùng mặt, ngứa vùng bẹn, sốt run, kèm ho ít đàm, môi khô, nứt kẻ, viêm loét họng, uống thuốc không giảm, nên nhập viện.

Tiền sử: Bệnh khai khoảng 10 năm nay, mỗi khi đau nhức bệnh thường mua toa thuốc Piroxicam, Ampicillin, Betamethason 0,5mg, Paracetamol 500 mg 1-2 ngày uống thì thấy khỏe, nên bệnh thường tự mua toa thuốc đó uống mỗi khi mệt mỏi và đau nhức cơ xương khớp. Đái tháo đường type 2 khoảng 1 năm (uống thuốc không rõ loại). Tổn thương da dạng mảng, đa cung vùng cẳng chân 2 bên, đã lâu khoảng 2 năm. Chưa ghi nhận tiền sử dị ứng thuốc trước đó, Các thuốc bác sĩ tư cấp trong đợt sốt này thì bệnh nhân không tìm thấy, không khai thác được.

Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng toàn thân: Bệnh tỉnh, tổng trạng béo phì, Ban sẩm màu rải rác vùng mặt và cổ, niêm mạc mắt sung huyết, viêm kết mạc. Môi khô, nứt kẻ, lưỡi dơ, viêm loét họng nhiều giả mạc. Không buồn nôn, nôn ói, không tiêu lỏng, tiểu hơi gắt, Ăn uống được khá, Than ho ít đàm.

Dấu hiệu sinh tồn: Huyết áp: 125/82 mmHg, Nhiệt độ: 39,9 oC, Mạch: 115 lần/phút, SpO2: 97 % khí phòng, Nhịp thở: 21 lần/ phút, Chiều cao 170 cm, Cân nặng 100 kg

Các cơ quan khác: Tim đều, phổi thô, bụng mềm, không điểm đau khu trú, gan lách sờ không chạm. Cổ mềm, không yếu liệt chi.

Kết quả cận lâm sàng:

ECG (08/9/2022): Nhịp nhanh xoang tần số 100 lần/phút

Mẫu bệnh phẩm: **MỦ (BÌU)**

Chủng vi sinh tìm thấy: Escherichia coli, ESBL (extended spectrum beta-lactamase): NEGATIVE Ertapenem: S Imipenem: S Amikacin: S Gentamicin: S

Khí máu động mạch: PO_2 76,3mmHg, PCO_2 26,2mmHg, pH 7,46, HCO_3 20,7mmol/L, SO_2 95,6%

Cấy máu: Tìm không thấy vi khuẩn

Công thức máu và sinh hóa máu: WBC 7,25 k/mm^3, Neu 3,53 k/mm^3, Lym 2,32 k/mm^3 , Eosinophile 820/mm^3, RBC 5,43 M/mm^3, PLT 268k/mm^3, CRP 311 mg/L, PCT 0,357 ng/mL, AST 43 U/L, ALT 88 U/L, HbA_{1C} 13,94% , Ure 9,2 mmol/L, GFR 56 ml/phút/1,73m^2, Định lượng IgE 2500 IU/ml, ion đồ bình thường.

X quang ngực thẳng: Quai chủ bung. Bóng tim không to. Không thấy thâm nhiễm phổi.

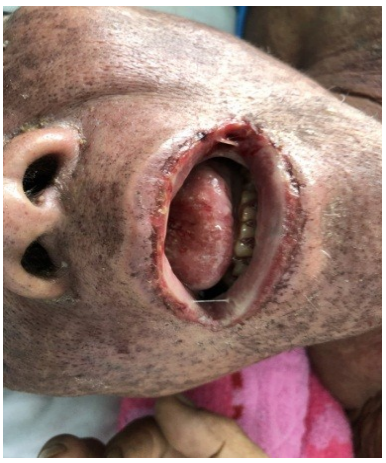
Chẩn đoán xác định: Hội chứng Stevens–Johnson do thuốc Piroxicam/Nhiễm trùng da bìu thứ phát do Escherichia coli nhạy Amikacin/Đái tháo đường típ 2/Suy thận cấp/Viêm kết mạc mắt/ Nhiễm nấm da.

Bệnh nhân được điều trị phác đồ:

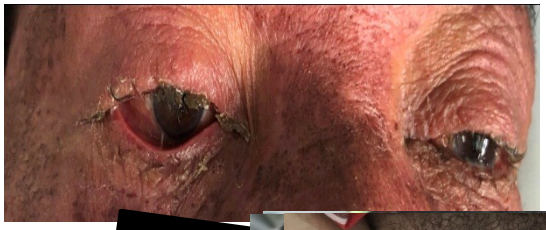
- Các thuốc chống viêm dị ứng: Corticoide đường toàn thân: Methylprednisolon 125mg 01 lọ tiêm mạch chậm, ngày 1, sau đó ngưng chuyển sang Corticoide dùng tại chỗ.
- Điều trị triệu chứng:
  - ✓ Chăm sóc các tổn thương niêm mạc như vệ sinh kỹ các niêm mạc miệng bằng nước muối sinh lý, bôi corticoide tại chỗ, chăm sóc mắt bằng thuốc Tobrex, vitol , Refresh tear.
  - ✓ Chăm sóc vùng da bị tổn thương theo quy trình chăm sóc, rửa vết thương vùng bẹn sinh dục, bôi corticoide tại chỗ
  - ✓ Bù nước điện giải, dinh dưỡng
- Điều trị bệnh nền kèm theo: kiểm soát đường huyết.

- Điều trị kháng sinh: Vancomycin phối hợp Metronidazol ngày 1, sau đó ngưng Metronidazol, duy trì vancomycin 14 ngày. Amikacin được dùng 10 ngày theo kết quả kháng sinh đồ cấy mủ ở bìu.
- Bệnh nhân được theo dõi và điều trị nội trú tại khoa Nội Nhiễm 16 ngày. Tiến triển da niêm bệnh tốt dần, niêm mạc dần hồi phục, tuy nhiên hiện bệnh vẫn còn sốt.

Hình 1. ***Hình ảnh bệnh nhân trước điều trị***









Hình 2. ***Hình ảnh bệnh nhân được cải thiện sau điều trị***

III. NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN

Chẩn đoán Hội chứng Steven–Johnson [1]

- Lâm sàng: Theo bệnh sử khai thác bệnh nhân sau khi dùng dùng thuốc , hôm sau biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, phát ban ở mặt ngứa sau đó tiến triển nhanh viêm lở loét các hốc tự nhiên như viêm kết mạc mắt, viêm loét trợt niêm mạc miệng, bộ phân sinh dục, kèm ban sẩm màu vùng mặt, cổ.
- Kết quả cận lâm sàng lúc vào viện có CRP tăng cao (tuy nhiên bạch cầu Neutrophil và procalcitonin trong giới hạn bình thường ít nghĩ tới tình trạng nhiễm trùng), tăng bạch cầu ái toan, định lượng IgE 2500UI/ml biểu hiện một tình trạng dị ứng. Tổn thương da BSA< 10% phù hợp Hội chứng Steven – Johnson.

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: *Hình ảnh ở da với ban đỏ da bóng nước nặng và hội chứng Stevens-Johnson/hoại tử biểu bì nhiễm độc* [1]

Ban đỏ da bọng nước đa dạng (bullous erythema multiforme, bullous EM)

Bóc tách <10% diện tích bề mặt cơ thể (BSA, Body Surface Area) **cộng** với hình bia điển hình **hoặc** các bia nhô cao, không điển hình.

Hội chứng Stevens-Johnson (SJS)

Bóc tách <10% BSA **cộng với** vết dát lan rộng **hoặc** các bia phẳng, không điển hình

Chồng lấp hội chứng Stevens-Johnson/hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS/TEN)

Bóc tách từ 10-30% BSA **cộng với** vết dát lan rộng **hoặc** các bia phẳng, không điển hình

Hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN, Toxic Epidermal Necrolysis)

Có đốm hoặc không có mụn nước: Bóc tách >30% BSA **cộng với** vết dát lan rộng **hoặc** bia phẳng, không điển hình

Không có đốm: Bóc tách >10% BSA **cộng với** không có bất kỳ vết dát hoặc hình bia nào

---

*** <u>Đánh giá mức độ bong da</u>**: BSA <10%

- Tổn thương đầu mặt cổ phía trước 4,5 đ
- Tổn thương cơ quan sinh dục 1đ

<u>* ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG CỦA HOẠI TỬ THƯỢNG BÌ NHIỄM ĐỘC (SCORTEN)</u> [3,4]

TT	Các yếu tố tiên lượng độc lập		Điểm	Tổng điêm bệnh nhân		Tỷ lệ tử vong
1	Tuổi	≥40 tuổi	1	59 tuổi	1	0-1 điểm: 3,2% 2 điểm 12.1% 3 điểm 35.3% 4 điểm 58.3% ≥5 điểm >90%
2	Bệnh ác tính*	Có	1	Không	0	
3	Diện tích bề mặt cơ thể tách rời	≥10%	1	5,5%	0	
4	Nhịp tim nhanh	≥120/phút	1	100	0	
5	Ure HT	>10 mmol/L	1	9,2	0	
6	Đường huyết	>14 mmol/L	1	13,6	0	
7	Bicarbonate HT	<20 mmol/L	1	20,7	0	
SCORTEN (score of toxic epidermal necrolysis)			7		1	
* Bệnh ác tính: ung thư tiến triển và các khối u ác tính về huyết học.						

=> Tổng điểm **SCORTEN** 1 đ (tỷ lệ tử vong khoảng 3,2%)

<u>*ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ CỦA THUỐC VỚI HOẠI TỬ BIỂU BÌ (ALDEN)</u>[(5)]

Tiêu chí	*Cho điểm*		*Quy tắc áp dụng*
Thời gian tiềm tàng: Thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc đến khi xuất hiện phản	Rất có khả năng:	+3	Từ 5 đến 28 ngày
	Có khả năng:	+2	Từ 29 đến 56 ngày
	Có thể:	+1	Từ 1 đến 4 ngày
	Không chắc chắn:	-1	Trên 56 ngày
	Loại trừ:	-3	Thuốc được bắt đầu sử dụng vào ngày hoặc sau ngày xuất hiện phản ứng
	Nếu trước đây bệnh nhân đã từng có phản ứng với thuốc này:		

Tiêu chí	*Cho điểm*		*Quy tắc áp dụng*
ứng	Rất có khả năng	+3	Từ 1 đến 4 ngày
	Có thể	+1	Từ 5 đến 56 ngày
Sự có mặt của thuốc trong cơ thể vào ngày xuất hiện phản ứng	Chắc chắn:	+0	Thuốc được tiếp tục sử dụng cho đến ngày xuất hiện phản ứng hoặc đã được ngừng trước ngày xuất hiện phản ứng ít hơn năm lần thời gian bán thải
	Nghi ngờ:	-1	Thuốc đã được ngừng trước ngày xuất hiện phản ứng nhiều hơn năm lần thời gian bán thải. Nghi ngờ xảy ra tương tác thuốc hoặc thay đổi chức năng gan thận làm ảnh hưởng tới nồng độ thuốc trong cơ thể
	Loại trừ:	-3	Thuốc đã được ngừng trước ngày xuất hiện phản ứng nhiều hơn năm lần thời gian bán thải. Không nghi ngờ xảy ra tương tác thuốc, chức năng gan thận không thay đổi
Sự ngừng sử dụng thuốc	Trung tính	+0	Ngừng dùng thuốc hoặc không rõ
	Âm tính	-2	Thuốc tiếp tục được dùng mà phản ứng cải thiện hoặc không xảy ra phản ứng
Đã từng xảy ra phản ứng với thuốc hoặc phản ứng tái diễn khi tái sử dụng thuốc	Dương tính đặc hiệu đối với bệnh **và** thuốc	+4	SJS/TEN xảy ra khi dùng chính thuốc này
	Dương tính đặc hiệu đối với bệnh **hoặc** thuốc	+2	SJS và TEN xảy ra khi dùng thuốc tương tự hoặc phản ứng tương tự xảy ra khi dùng chính thuốc này
	Dương tính không đặc hiệu	+1	Phản ứng khác tương tự xảy ra sau khi dùng thuốc tương tự
	Không làm/không rõ	+0	Không biết tiền sử dùng thuốc này/không dùng lại thuốc
	Âm tính:	-2	Đã dùng thuốc này mà không xảy ra phản ứng/Dùng lại thuốc mà không xảy ra phản ứng
Xếp hạng của thuốc theo nguy cơ xảy ra phản ứng	Rất liên quan	+3	Thuốc thuộc danh sách "**nguy cơ cao**"
	Liên quan	+2	Thuốc thuộc danh sách "**Nguy cơ có ý nghĩa**"
	Nghi ngờ	+1	Thuốc thuộc danh sách "**chưa đánh giá được nguy cơ**" hoặc đã có ghi nhận xảy ra phản ứng với thuốc theo kết quả một vài báo cáo, báo cáo dịch tễ
	Không nghi ngờ	-1	Thuốc thuộc danh sách "**không có nguy cơ**"
	Không rõ:	+0	Các thuốc khác (bao gồm cả những thuốc mới lưu hành và thuốc gây nhiễu)
Điểm trung gian = Tổng điểm tất cả các tiêu chí trên			
Nguyên nhân khác	Có thể:	-1	Trong một ca báo cáo, nếu có ít nhất một thuốc có điểm trung gian > 3 thì trừ một điểm từ điểm trung gian của các thuốc có điểm trung gian 3
Tổng điểm: -12 đến 10			<0: Rất không chắc chắn; 0 – 1: Không chắc chắn; 2 – 3: Có thể; 4 – 5: Có khả năng; ≥6: Rất có khả năng

TIẾN HÀNH TÍNH ĐIỂM TRÊN THANG ALDEN VỚI NHỮNG THUỐC MÀ BỆNH NHÂN ĐÃ KHAI:

Thuốc Piroxicam:

- *Thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc đến khi xuất hiện phản ứng*: 5-28 ngày =>**3đ**
- *Sự có mặt của thuốc trong cơ thể vào ngày xuất hiện phản ứng*: thời gian bán thải của piroxicam là 20-70 giờ[6](100 giờ-350 giờ), ở bệnh nhân từ khi dừng thuốc đến khi xuất hiện triệu chứng như ngứa bẹn, ngứa mặt sốt run, viêm loét họng là 120-144 giờ (5 – 6 ngày), vậy thời điểm dùng thuốc đến khi khởi phát triệu chứng < 5 lần thời gian bán thải của thuốc => **0 đ**
- Việc ngừng sử dụng thuốc: Đã dừng sử dụng => **0 đ**
- Tiền sử sử dụng thuốc: Bệnh nhân khai đã dùng loại thuốc này khoảng 10 năm, uống mỗi khi thấy mệt mỏi và đau nhức => Dùng lại thuốc này mà không có bất kỳ phản ứng nào=> **-2 đ**
- Xếp hạng của thuốc theo nguy cơ xảy ra phản ứng: Nhóm nguy cơ cao[4][7] => **3đ**
- Nguyên nhân khác: **0 đ**

Điểm cuối: **4** đ => **có khả năng**

Thuốc Ampicillin

- Thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc đến khi xuất hiện phản ứng: 5- 28 ngày=> **3đ**
- Sự có mặt của thuốc trong cơ thể vào ngày xuất hiện phản ứng: thời gian bán thải của ampicillin là 1,68 giờ[6], thuốc được dừng sử dụng > 5 lần thời gian bán thải của thuốc, có thay đổi chức năng gan thận (ALT 88 U/L, GFR 56 ml/phút/1,73m^2)=> **-1 đ**
- Việc ngừng sử dụng thuốc: Đã dừng sử dụng => **0 đ**
- Tiền sử sử dụng thuốc: Bệnh nhân khai đã dùng loại thuốc này khoảng 10 năm, uống mỗi khi thấy mệt mỏi và đau nhức => Dùng lại thuốc này mà không có bất kỳ phản ứng nào=> **-2đ**
- Xếp hạng của thuốc theo nguy cơ xảy ra phản ứng: Nhóm nguy cơ có ý nghĩa[7]=> **2đ**
- Nguyên nhân khác: điểm trung gian thuốc này 2 => **-1 đ**

Điểm cuối: **1** đ => **không chắc chắn**

Thuốc Paracetamol

- Thời gian từ khi bắt đầu dùng thuốc đến khi xuất hiện phản ứng: 5- 28 ngày=> **3đ**
- Sự có mặt của thuốc trong cơ thể vào ngày xuất hiện phản ứng: thời gian bán thải của paracetamol là 1,25 - 3 giờ[6], thuốc được dừng sử dụng > 5 lần thời gian bán thải của thuốc, có thay đổi chức năng gan thận (ALT 88 U/L, GFR 56 ml/phút/1,73m^2)=> **-1đ**
- Việc ngừng sử dụng thuốc: Đã dừng sử dụng => **0 đ**
- Tiền sử sử dụng thuốc: Bệnh nhân khai đã dùng loại thuốc này khoảng 10 năm, uống mỗi khi thấy mệt mỏi và đau nhức => Dùng lại thuốc này mà không có bất kỳ phản ứng nào=> **-2 đ**
- Xếp hạng của thuốc theo nguy cơ xảy ra phản ứng: Nhóm không rõ nguy cơ[7]=> **0đ**

- Nguyên nhân khác: điểm trung gian thuốc này 2 => **-1 đ**

Điểm cuối: **-1** đ => **Rất không chắc chắn**

=>Vậy từ thang đánh giá ALDEN đã xác định được thuốc Piroxicam là thuốc có khả năng gây ra Hội chứng Steven Johnson trên bệnh nhân này.

ĐIỀU TRỊ [1.2]

- **Chăm sóc hỗ trợ:**

✓ *Bệnh nhân được bù dịch, dinh dưỡng*, chất điện giải, kiểm soát đường huyết, chức năng thận bệnh nhân được cải thiện eGFR từ 56 lên 71ml/ phút/1,73m^2.

✓ *Kiểm soát sốt và cơn đau*: truyền paracetamol

✓ *Chăm sóc vết thương:* Tẩy tế bào chết lặp đi lặp lại trên da và chăm sóc vết thương "không làm rách da", da hoại tử được giữ nguyên như một loại băng sinh học.

✓ *Bệnh nhân được chăm sóc da, khám mắt:* và chăm sóc mắt theo chuyên khoa để hạn chế biến chứng loét giác mạc, mù mắt cho bệnh nhân, tránh bội nhiễm.

✓ *Phòng ngừa nhiễm trùng:* Xử lý vô trùng, thuốc sát trùng tại chỗ và nuôi cấy giám sát các vị trí có thể bị bội nhiễm.

✓ *Theo dõi liên quan đến hô hấp*.

- Việc điều trị kháng sinh Vancomycin ban đầu là chưa phù hợp vì kết quả cận lâm sàng ban đầu không đủ nghĩ đến tình trạng nhiễm trùng, việc điều trị kháng sinh dự phòng cũng chưa được khuyến cáo.
- Điều trị nhiễm trùng thứ phát theo kháng sinh đồ là phù hợp.
- Hiện tại bệnh nhân còn giảm sốt cần tầm soát thêm những nhiễm trùng thứ phát, nấm khác, tầm soát tác nhân dị ứng trong những thuốc đang sử dụng.
- Tránh dùng thuốc trong tương lai: BN cần được hướng dẫn về việc tránh dùng thuốc thủ phạm. Tái nhiễm dễ tử vong. Ghi thông tin dị ứng trên vòng đeo tay hoặc vòng đeo cổ.
- **Ghi chú**: Các chất ức chế miễn dịch hoặc điều hòa miễn dịch toàn thân như: corticoid toàn thân, globulin miễn dịch tiêm (IVIG), cyclosporine, lọc huyết tương và TNF-α, đã được dùng để điều trị SJS/TEN, nhưng bằng chứng về lợi ích còn hạn chế và chưa thuyết phục.

THAM KHẢO

1. High Wa, Adkinson NF, Levy ML, Mockenhaupt M. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, Oct 2022.
2. Lee HY, Adkinson NF, Levy ML, Mockenhaupt M, Corona R. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Management, prognosis, and long-term sequelae. UpToDate, Oct 2022.

3. Guégan S, Garin SB, Poszepczynska-Guigné E, Roujeau JC, Revuz J. Performance of the SCORTEN During the First Five Days of Hospitalization to Predict the Prognosis of Epidermal Necrolysis.Joutnal of Investigative Dermatology. Vol. 126 (2), Feb 2006: 272-276.
4. Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M, Roujeau JC, Revuz J, Wolkenstein P. SCORTEN: a severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol. 2000 Aug;115(2):149-53.
5. Dược thư quốc gia Việt Nam (2018), Bộ Y tế, tr.199, 1160
6. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu (2015), Bộ Y tế, tr.133-144
7. Nguyễn Khắc Dũng, Trần Thu Thuỷ, Đào Thu Trang, Nguyễn Văn Đoàn, Bùi Văn Dân, Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dược Học số 494, 06/2017, Bộ Y tế. Tr.07-08.
8. Roni P Dodiuk-Gak, Wen-hung chung, Laurence Valey-Allanore, Neil H Shear. Stevens-John and Toxic Epidermal Necrolysis. NIH, Dec 2015
9. Amanda M. Oakley, Karthik Krishnamurthy. Steven Johnson Syndrom. NCBI, Aug 2022

HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VỚI ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Nguyễn Văn Dũng, Châu Hữu Hầu

TÓM TẮT

Mục tiêu: Hiệu quả của nội soi điều trị phối hợp với ức chế bơm proton ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do loét dạ dày tá tràng (LDD-TT). **Phương pháp**: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu về nội soi can thiệp điều trị ở các bệnh nhân LDD-TT bị XHTH trong 23 tháng từ đầu tháng 1/2020 đến hết tháng 11/2022 với 48 bệnh nhân tại bệnh viện Nhật Tân, tỉnh An Giang. **Kết quả**: Bệnh nhân nam mắc bệnh LDD-TT có biến chứng XHTH nhiều hơn nữ với tỷ số 5:1. Bệnh nhân nữ có lứa tuổi mắc LDD-TT từ 58-84 muộn hơn bệnh nhân nam với lứa tuổi 22-94. Khi phân loại XHTH theo Forrest, chúng tôi chỉ gặp loại F1a, F1b và F2a với các tỷ lệ 16,7%, 31,2% và 52,1%. Phân loại ổ loét đường tiêu hóa trên có biến chứng XHTH: LTT chiếm 41,7%, và LDD chiếm 58,3%, tỷ lệ LTT/LDD là 0.71%. Trong suốt nghiên cứu, chỉ có 1 trường hợp LDD-TT (tỷ lệ 2,1%) có XHTH tử vong và 2 trường hợp phải nội soi can thiệp lần 2 (4,3%). **Kết luận**: Bệnh LDD-TT có biến chứng XHTH ở bệnh nhân nữ xảy ra ở lứa tuổi muộn hơn bệnh nhân nam (58-84 so với 22-94). LTT ít hơn LDD với tỷ lệ 0,71%. Tỷ lệ tử vong và chảy máu tái phát cần nội soi lần 2 ít gặp với tỷ lệ lần lượt là 2,1% và 4,3%.

Từ khóa: Loét dạ dày, loét tá tràng, ức chế bơm proton (ƯCBP), xuất huyết tiêu hóa

Viết tắt: LDD: loét dạ dày; TM, tĩnh mạch; TT, tá tràng; TTM, truyền tĩnh mạch; XHTH, xuất huyết tiêu hóa.

SUMMARY

EFFICIENCY OF ENDOSCOPIC THERAPY WITH PROTON PUMP INHIBITORS IN PATIENTS WITH BLEEDING PEPTIC ULCER

Objectives: Efficacy of endoscopic therapy in combination with proton pump inhibitors in patients with gastrointestinal bleeding due to peptic ulcer. **Methods**: Retrospective and prospective study of interventional endoscopic treatment in patients with bleeding complications due to peptic ulcer in 23 months from the beginning of Jan. 2020 to the end of Nov. 2022 with 48 patients at Nhat Tan hospital, An Giang province. **Results**: Male patients with peptic ulcer had more GI complications than female patients with a ratio of 5:1. Age of male patients with bleeding peptic ulcer is younger than female patients was 22 to 94 versus 54 to 84. When classifying bleeding peptic ulcer according to Forrest, we only encountered types F1a, F1b and F2a with rates of 16.7%, 31.2% and 52.1%, respectively. Classification of hemorrhagic peptic ulcers: Duodenal ulcer accounted for 41.7% and gastric ulcer for 58.3%, the ratio of

duodenal/gastric ulcer was 0.71%. During the study, only 1 case of peptic ulcer (2.1%) had fatal by bleeding complication and 2 cases required second endoscopic intervention (4.3%). **Conclusion**: Peptic ulcer with bleeding complications in female patients occurred at a later age than male patients (58-84 versus 22-94). Duodenal ulcer is less than gastric ulcer with a ratio of 0.71%. Mortality and recurrent bleeding requiring second endoscopy were rare with rates of 2.1% and 4.3%, respectively.

Keywords: Gastroduodenal ulcer, proton pump inhibitor, gastroduodenal bleeding

Abbreviation: PPIs, proton pump inhibitors.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong một nghiên cứu của WHO, hiện có khoảng 8,09 triệu người mắc LDD-tá tràng (LDD-TT) vào năm 2019, tăng 25,82% so với năm 1990 với 6,43 triệu. Trên thế giới, Kiribati có tỷ lệ lưu hành chuẩn hóa theo tuổi cao nhất [330,32 (286,98–379,81) trên 100.000 dân]. Không có số liệu LDD-TT ở Việt Nam, nhưng theo số liệu của WHO năm 2020, số ca tử vong hằng năm do bệnh viêm LDD-TT ở Việt Nam lên tới 957 người hay 0,14% tổng số ca tử vong. Tỷ suất chết điều chỉnh theo tuổi ở Việt Nam là 0,86 trên 100.000 dân, đứng thứ 155 trên thế giới. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ khác biệt với tỷ lệ 2,35:1.[1]

LDD-TT là một khiếm khuyết ở niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng lan rộng đến lớp mảnh cơ niêm và các lớp sâu hơn. LDD có thể biểu hiện khó tiêu hoặc có thể không triệu chứng (khoảng 70%), về sau có thể xuất huyết hoặc thủng. LDD-TT chảy máu khá phổ biến với các biểu hiện như buồn nôn, nôn ra máu hoặc tiêu phân đen. Một số bệnh nhân nặng có thể tiêu ra máu đen và hạ huyết áp [2]. Đa số bệnh nhân bị LDD-TT sẽ ngừng chảy máu tự nhiên. Nhưng một số bệnh nhân chảy máu tái phát và cần điều trị nội soi. Nếu nội soi thất bại, cần can thiệp động mạch hoặc phẫu thuật [3].

Thang điểm xuất huyết Glasgow-Blatchford (GBS) hay dùng để xác định nguy cơ của bệnh nhân XHTH trên. Bệnh nhân có điểm ≤7 (nguy cơ thấp) không cần giám sát chặt và bệnh nhân có điểm ≥8 (nguy cơ cao) cần phải can thiệp sớm. [4]

Theo ACG Mỹ năm 2021, sau khi nội soi cầm máu, tiêm ức chế bơm proton (PPI) liều cao liên tục hoặc ngắt quãng trong 3 ngày, sau đó có thể dùng PPI uống 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần đầu điều trị sau nội soi. Khi chảy máu tái phát, lặp lại nội soi. Nếu nội soi thất bại, chuyển mổ hoặc chuyển tuyến trên để thuyên tắc mạch [5,6].

Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm mục tiêu xác định nguy cơ của bệnh nhân XHTH do LDD-TT để can thiệp qua nội soi tiêu hóa trên phối hợp với ức chế proton liều cao.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện ở các bệnh nhân XHTH do LDD-TT được chẩn đoán bằng nội soi tiêu hóa trên đến điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu có can thiệp điều trị.

Cỡ mẫu và thời gian nghiên cứu: Chọn mẫu thuận tiện thời gian 23 tháng từ đầu tháng 1/2020 đến hết tháng 11/2022 với 48 bệnh nhân.

Tiến hành thủ thuật nội soi dạ dày tá tràng:

Cho bệnh nhân nằm nghiêng trái, 2 chân co nhẹ, đưa ống soi từ từ vào đường miệng, quan sát đáy lưỡi, lưỡi gà, nắp thanh môn. Quan sát chỗ nối hầu - thực quản, bảo bệnh nhân nuốt đồng thời đẩy nhẹ ống nội soi vào thực quản. dạ dày, ghi nhận các hình ảnh tổn thương, đưa ống soi qua lỗ môn vị, khảo sát hành tá tràng đến D2 tá tràng.

Phương tiện, vật liệu nghiên cứu và kỹ thuật kẹp cầm máu qua nội soi

Ống soi dạ dày Fujinon XL-4450 (Nhật) với kênh sinh thiết 2,8 mm, nguồn sáng Xenon và bộ xử lý Fujinon 4450 sản xuất năm 2018.

Kẹp clip cầm máu: Clip cầm máu Anrei, 2 cánh, xoay được của Cty Anrei Medical (Hangzhou) có chiều dài 1950 mm, góc mở của cánh clip 135 độ, độ mở rộng 12mm.

Kỹ thuật kẹp clip: Luồn clip qua kênh sinh thiết, điều chỉnh ống soi sao cho clip vuông góc với tổn thương gây xuất huyết.

Ức chế bơm proton: Sau nội soi kẹp cầm máu, dùng ức chế bơm proton (PPI) dạng tiêm truyền là Esomeprazol của Cty Bidiphar, 80mg tiêm TM; sau đó 8mg/giờ TTM qua bơm tiêm điện trong 72 giờ; hoặc dùng PPI dạng uống,

Xử lý số liệu: Tất cả dữ liệu được nhập và phân tích trong SPSS (phiên bản 20). Dùng crosstabs để kiểm định các biến định tính. Dùng One-way ANOVA để so sánh 2 số trung bình. Số trung bình ± Độ lệch chuẩn. Có ý nghĩa khi $p<0.05$.

Đạo đức trong nghiên cứu: Các đối tượng được thông báo chi tiết về nội dung, mục tiêu nghiên cứu và lấy ý kiến đồng thuận. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo vệ.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. ***Lứa tuổi và giới tính của bệnh nhân LDD-TT xuất huyết***

Lứa tuổi	Giới tính				Cộng	X^2	p
	Nữ	Tỷ lệ%	Nam	Tỷ lệ %		3,566	>0.05
22-49	0	0%	13	100%	13		
50-94	8	22,9%	27	77,1%	35		
Cộng	8	16,7%	40	83,3%	48		

Nhận xét: Do số bệnh nhân nữ chỉ có 8, tuổi từ 58-84; nam từ 22 đến 94, không có phân bố chuẩn, không có ý nghĩa thống kê, p >0,05. Tỷ lệ giữa nam và nữ là 5/1.

Bảng 2. ***Phân loại XHTH theo Forrest***

Loại	Diễn giải	Số bệnh nhân	Tỷ lệ %
1a	Máu bắn thành tia	8	16,7%
1b	Máu chảy rỉ rả	15	31,2%
2a	Lộ mạch máu	25	52,1%
Cộng		48	100%

Nhận xét: Chỉ có 3 loại XHTH: F1a, máu bắn thành tia: 8 bệnh nhân (16,7%); F1b, máu chảy rỉ rả: 15 bệnh nhân (31,2%) và F2a, lộ mạch máu: 25 trường hợp (52,1%).

Bảng 3. ***Thang điểm Glasgow-Blatchford với nguy cơ XHTH***

Nguy cơ	Điểm Glasgow-Blatchford	Số lượng	Tỷ lệ %
Nguy cơ ít ≤7	4-7	12	25%
Nguy cơ cao ≥8	8-17	36	75%
Tổng cộng		48	100%

Nhận xét: Do số bệnh nhân ít, chúng tôi phân ra 2 nhóm: Nhóm nguy cơ thấp ≤7 có 12 trường hợp (25%) và nhóm nguy cơ cao 36 (75%). Những bệnh nhân nhẹ hơn từ 0 đến 3, đa số không cần can thiệp, không nằm viện, không đưa vào nghiên cứu.

Bảng 4. ***Vị trí xuất huyết dạ dày và tá tràng***

Vị trí xuất huyết	**N**	**Tỷ lệ %**	**Vị trí xuất huyết**	**N**	**Tỷ lệ %**
Dạ dày	**28**	**58,3%**	**Hành tá tràng**	**20**	**41,7%**
Hang vị	13	27,1%	Mặt trước	13	27,1%
Thân vị	9	18,7%	Mặt sau	5	10,4%
Góc bờ cong nhỏ	5	10,4%	D1, D2	2	4,2%
Tiền môn vị	1	2,1%	Mặt bên	0	0%
Tá tràng	**20**	**41,7%**	**Dạ dày**	**28**	**58,3%**

Nhận xét: ***LDD:*** chiếm 28/48 trường hợp LDD-TT, chiếm 58,3% bao gồm loét hang vị 27.1%, thân vị 18.7%, góc bờ cong nhỏ 10.4% và tiền môn vị 2,1%. Trong khi đó, ***LTT:*** có 20 trường hợp, chiếm 41,7% bao gồm loét mặt trước 27,1%, loét mặt sau 10,4% và loét ở D1, D2 là 4,2%. Tỷ lệ LTT thấp hơn so với LDD 20/28=0.71%.

Bảng 5. ***Mô tả và một số yếu tố can thiệp ở bệnh nhân LDD-TT***

Phân loại Forrest	Kích thước ổ loét DD	Kích thước ổ loét HTT	Thời gian nội soi	Truyền máu (ml)	Số clip dùng	Số ngày nằm viện
F1a	6.5 ± 2.1	4,6 ± 2.3	1.6 ± 0.9	1.125 ± 0,353	2.8 ± 0.5	9.2 ± 8.3
F1b	6.1 ± 2.1	4,7 ± 2.5	1.5 ± 0.5	1.466 ± 0.516	2.7 ± 1.3	4.9 ± 2.0
F2a	6.5 ± 2.4	4.9 ± 2.4	1.6 ± 0.5	1.480 ± 0,510	2.1 ± 0.9	4.9 ± 2.9
Ý nghĩa, p	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05

Nhận xét: Kích thước các ổ LDD, tá tràng, thời gian nội soi, số lượng máu truyền không chênh lệch nhiều, p >0.05. Trong khi đó, số ngày nằm viện cho nhóm F1a cao hơn 2 nhóm còn lại F1b và F2a, với p <0,05.

Bảng 6. ***Xuất huyết tái phát và tử vong sau điều trị can thiệp qua nội soi***

	Xuất huyết tái phát			Tử vong	
Giới	N	XH tái phát	Tỷ lệ (%)	Tử vong	Tỷ lệ (%)
Nữ	8	0	(0%)	0	(0%)
Nam	40	2	38 (5,3%)	1	39 (2,6%)
Cộng	48	2	46 (4,3%)	1	47 (2,1%)

Nhận xét: Có 2 bệnh nhân nam 33 và 61 tuổi mắc xuất huyết tái phát sau can thiệp qua nội soi chiếm (4,3%). Tử vong 1 trường hợp chiếm (2,1%), đó là một bệnh nhân nam 76 tuổi, bị XHTH do loét HTT có bệnh phối hợp: xơ gan, đái tháo đường típ 2.

IV. BÀN LUẬN

Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu có can thiệp ở các bệnh nhân LDD-TT bị XHTH trong 23 tháng từ đầu tháng 1/2020 đến hết tháng 11/2022 với 48 bệnh nhân. Bệnh nhân được hồi sức bằng truyền dịch, nâng thể trạng, truyền máu, điều trị các bệnh đi kèm. Khi bệnh nhân tương đối ổn, chúng tôi nội soi dạ dày tá tràng để thám sát và nếu cần, can thiệp bằng nội soi kẹp clip cầm máu ổ loét. Khi can thiệp xong, PPI được dùng (Esomeprazol) tiêm TM 80 mg, sau đó tiếp tục dùng Esomeprazol 8 mg/giờ truyền TM qua bơm tiêm điện trong 72 giờ, hoặc dùng PPI dạng uống để ngừa chảy máu tái phát [6].

Trong số 48 bệnh nhân, số bệnh nhân nữ mắc LDD-TT chỉ có 8, trong khi đó nam chiếm đa số với 40 bệnh nhân. Tỷ lệ giữa nam và nữ chiếm 5:1 cao hơn gấp đôi báo cáo của WHO về bệnh này ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với tỷ lệ mắc LDD-TT giữa nam và nữ là 2,35:1 [1]. So với nghiên cứu của Huỳnh Hiếu Tâm, chênh lệnh giữa nam và nữ là 3,75 ở nhóm được cầm máu bằng dung dịch nướcc muối sinh lý và epinephrin (HSE), và chênh lệch này là 2,5 ở nhóm cầm máu bằng kẹp clip qua nội soi. [8]

Lứa tuổi bệnh nhân nữ lại mắc LDD-TT từ 58 đến 84 tuổi, muộn hơn bệnh nhân nam mắc bệnh này ở lứa tuổi từ 22 đến 94 cho thấy bệnh LDD-TT có biến chứng xuất huyết xảy ra khá phổ biến và xảy ra sớm hơn ở nam giới.

Khi phân loại XHTH theo Forrest, do số bệnh nhân ít, chúng tôi chỉ gặp loại F1a với 8 trường hợp (máu bắn thành tia, 16,7%); loại F1b với 15 trường hợp (máu chảy rỉ rả, 31,2%) và loại 2a với 25 trường hợp (lộ mạch máu, 52,1%). Trong nghiên cứu của chúng tôi, khả năng xuất huyết tái phát ít một phần do đa số thuộc loại F2a chiếm 52,1% các trường hợp xuất huyết do LDD-TT. Huỳnh Hiếu Tâm cũng có kết quả tương tự về tỷ lệ của loại F2a với 22 trường hợp (57,9%) ở nhóm ở nhóm được cầm

máu bằng dung dịch nước muối ưu trương + epinephrin và 19 trường hợp (52,8%) ở nhóm cầm máu bằng kẹp clip qua nội soi [8].

Khi xếp theo thang điểm Glasgow-Blatchford với nguy cơ XHTH [7], bệnh nhân chia thành 2 nhóm: Nhóm nguy cơ ít ≤7 có 12 trường hợp, chiếm 25% và nhóm nguy cơ cao 36 trường hợp, chiếm 75%. Những trường hợp nhẹ hơn từ 0 đến 3 của thang điểm này thường không cần can thiệp, không nằm viện, nên không đưa vào nghiên cứu.

Phân loại ổ loét đường tiêu hóa trên: *LDD:* chiếm 28 trường hợp trong số 48 trường hợp LDD-TT, chiếm 58,3% bao gồm từ nhiều đến ít là loét hang vị 27.1%, thân vị 18.7%, góc bờ cong nhỏ 10.4% và tiền môn vị 2,1%. Trong khi đó, *LTT:* có 20 trường hợp, chiếm 41,7% bao gồm loét mắt trước 27,1%, loét mặt sau 10,4% và loét ở D1, D2 là 4,2%. Theo nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ LHTT thấp hơn so với LDD 20/28=0.71%. Nhưng nghiên cứu của Mille **và cs, LTT chảy máu thường xuyên hơn LDD 1,3–2,3 lần [4]**

Một số yếu tố can thiệp ở bệnh nhân LDD-TT về mô tả kích thước ổ loét, thời gian nội soi, số lượng máu truyền, số clip dùng và số ngày nằm viện đều có số liệu gân tương đương nhau nên không khác biệt có ý nghĩa thống kê với p >0,05. Nhưng số ngày nằm viện ở nhóm có nguy cơ cao (F1a) cao hơn nhóm nguy cơ trung bình (F1b) và nhóm nguy cơ thấp (F2a), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05.

Theo nghiên cứu của chúng tôi, số trường hợp cần phải nội soi can thiệp lần 2 do chảy máu tái phát là 2, chiếm tỷ lệ 4,3%. Kết quả này hơi cao so với nghiên cứu Huỳnh Hiếu Tâm với tỷ lệ thất bại kẹp cầm máu lần đầu là 2,8% [8]. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 1 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 2,1%, do loét hành tá tràng là một người nam, 76 tuổi, bị XHTH có bệnh phối hợp, số điểm Blatchfor là 11, nôn và đại tiện ra máu, số ngày nằm viện: 4 ngày. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Huỳnh Hiếu Tâm, tỷ lệ tử vong của kẹp cầm máu là 2,8%.

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu can thiệp điều trị LDD-TT có XHTH qua nội soi phối hợp PPI trong 23 tháng với 48 bệnh nhân. Bệnh nhân nam mắc chứng bệnh này nhiều hơn nữ với tỷ số 5:1. Bệnh nhân nữ có lứa tuổi mắc LDD-TT có xuất huyết từ 58 đến 84 tuổi muộn hơn bệnh nhân nam mắc bệnh này với lứa tuổi từ 22 đến 94. Khi phân loại XHTH theo Forrest, chúng tôi chỉ gặp loại F1a, F1b và F2a với các tỷ lệ 16,7%, 31,2% và 52,1%. Phân loại ổ loét đường tiêu hóa trên có biến chứng XHTH: LTT chiếm 41,7%, và LDD chiếm 58,3%, tỷ lệ LTT/LDD là 0.71%. Trong suốt nghiên cứu, chỉ có 1 trường hợp LDD-TT có xuất huyết (tỷ lệ 2,1%) tử vong và 2 trường hợp phải nội soi can thiệp lần 2 (4,3%).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Xie X, Ren K, Zhou Z, Dang C, Zhang H.** The global, regional and national burden of peptic ulcer disease from 1990 to 2019: a population-based study. *BMC Gastroenterology*, Vol. 22: 58, 10 Feb, 2022.
2. **Vakil NB, Feldman M, Grover S.** Peptic ulcer disease: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, Oct 2022
3. **Saltzman JR, Feldman M, Travis AC.** Overview of the treatment of bleeding peptic ulcers. UpToDate, Oct 2022
4. **Mille M, Engelhardt T, Stier A.** Bleeding Duodenal Ulcer: Strategies in High-Risk Ulcers. Clinical Therapeutic Review. Visc Med 2021;37:52–62.
5. **Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Grigorios I. Leontiadis GI.** ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding, Am J Gastroenterol 2021;116:899–917.
6. **Cheng HC, Sheu BS.** Intravenous proton pump inhibitors for peptic ulcer bleeding: Clinical benefits and limits. *World J Gastrointest Endosc* 2011 March 16; 3(3): 49-56
7. **Chatten K , Purssell H, Banerjee AK, Soteriadou S, Ang Y.** Glasgow Blatchford Score and risk stratifications in acute upper gastrointestinal bleed: can we extend this to 2 for urgent outpatient management? Clinical Medicine 2018 Vol 18, No 2: 118–22.
8. **Huỳnh Hiếu Tâm.** Nghiên cứu hiệu quả của tiêm hoặc kẹp cầm máu qua nội soi phối hợp với thuốc ức chế bơm proton liều cao tĩnh mạch ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Luận án TSYH, Đại học Y khoa Huế, 2019.

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
XỬ TRÍ ĐA POLYP VỊ THÀNH NIÊN GÂY LỒNG RUỘT

Hồ Trung Nghĩa; Nguyễn Văn Dũng; Châu Hữu Hầu

TÓM TẮT

Tỷ lệ mắc polyp vị thành niên hiếm gặp, ước tính khoảng 1 người trên 100.000 người mỗi năm. Lồng ruột non do polyp càng hiếm hơn. Khi xử trí lồng ruột do polyp, cần chẩn đoán chính xác polyp này là đơn độc hay còn nhiều polyp khác để xử trí thích hợp nhằm tránh diễn biến không có lợi về sau. Nếu là bệnh đa polyp, thì việc mổ nội soi xử trí lồng ruột, kết hợp việc đưa máy nội soi tiêu hóa vào trong lòng ruột non để cắt triệt để các polyp khác, là việc phối hợp khả thi và hiệu quả nhằm cắt triệt để các polyp trong ruột non. Chúng tôi xin báo cáo trường hợp phối hợp phẫu thuật nội soi và nội soi tiêu hóa xử trí lồng ruột non do bệnh polyp vị thành niện tại bệnh viện Nhật Tân.

Từ khóa: Juvenile polyposis, harmartoma, intestinal intussusception

SUMMARY

ONE CASE OF MANAGEMENT OF ADOLESCENT POLYPOSIS CAUSING INTESTINAL INTUSSUSCEPTION

The incidence of juvenile polyposis is rare, estimated at 1 per 100,000 people per year. Intussusception due to polyps is even rarer. When managing polyposis intussusception, it is necessary to accurately diagnose whether this polyp is alone or there are many other polyps for appropriate management to avoid adverse events later. If it is a polyposis, then laparoscopic management of intussusception, combined with the introduction of a gastrointestinal endoscope into the lumen of the small intestine to thoroughly remove other polyps, is a feasible and effective combination for radical resection. to polyps in the small intestine. We would like to report a case of combined endoscopic surgery and gastrointestinal endoscopy to treat small bowel intussusception due to juvenile polyposis at Nhat Tan hospital.

Keywords: Juvenile polyposis, harmartoma, intestinal intussusception

I. MỞ ĐẦU

Tỷ lệ mắc polyp vị thành niên được ước tính là 1 trên 100.000 người mỗi năm. Nam và nữ có tỷ lệ mắc bệnh như nhau, trong đó người Bắc Âu có tỷ lệ mắc JP cao hơn so với các nhóm khác. Polyp vị thành niên là các tổn thương u mô thừa có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, mặc dù chúng tương đối phổ biến hơn ở thời thơ ấu. Các polyp đại tràng ở vị thành niên lẻ tẻ xảy ra ở 2% trẻ em dưới 10 tuổi, thường đơn độc và không có nguy cơ ung thư đại trực tràng. Polyp vị thành niên dẫn đến xuất huyết tiêu

hóa dưới hoặc sa qua trực tràng cần phải cắt polyp. Những BN không có triệu chứng không cần điều trị. Hội chứng đa polyp ở trẻ vị thành niên là một tình trạng có tính trội ở thể đa polyp u mô thừa đường tiêu hóa. Những người bị JPS có nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng và dạ dày. [7]

Bệnh nhân JP có xu hướng phát triển polyp mô thừa khắp đại tràng và một tập hợp con của chúng cũng ở đường tiêu hóa trên, phổ biến nhất là ở dạ dày. một số trường hợp polyp có thể phát triển quá nhanh, dị dạng và có thể gây các biến chứng như tắc ruột, lồng ruột, chảy máu và về lâu dài có một tỷ lệ có khả năng thành ung thư, do đó nên tiến hành sàng lọc chặt chẽ và quản lý tích cực. [1], [3]

Chúng tôi báo cáo một trường hợp được chẩn đoán là hội chứng đa polyp vị thành niên dựa vào bảng tiêu chuẩn sau:

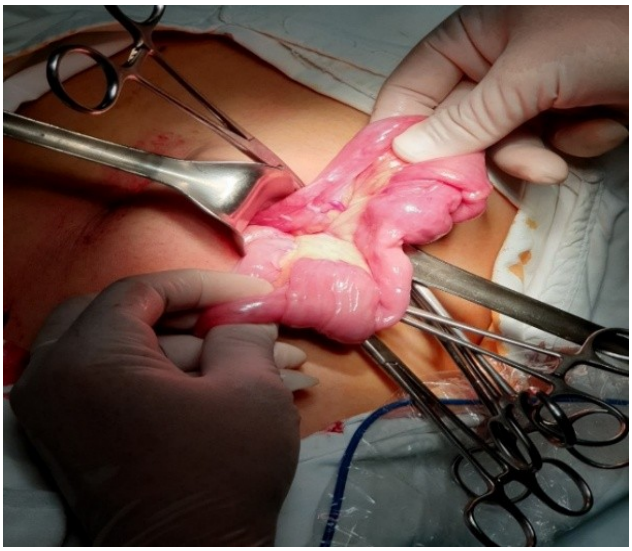
Tiêu chuẩn chẩn đoán đa polyp vị thành niên

Tiêu chuẩn chẩn đoán để nhận biết Hội chứng polyp mô thừa *[13]*

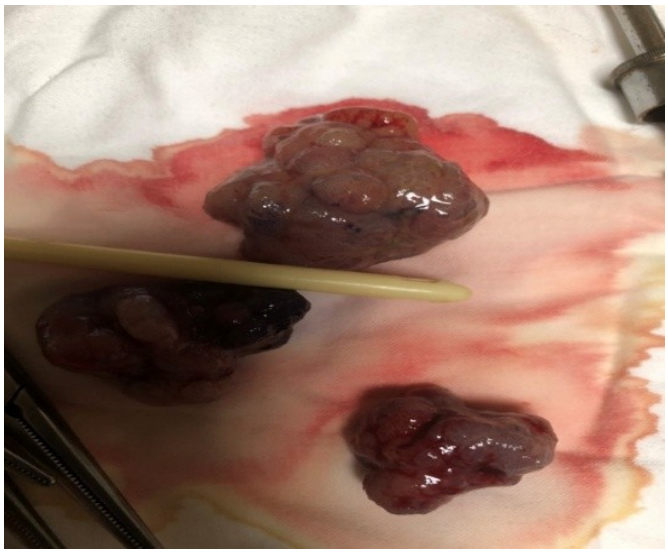
Hội chứng	**Tiêu chí chẩn đoán Hội chứng đa polyp mô thừa**
Đa polyp vị thành niên	• Nhiều polyp vị thành niên (ít nhất 3) trong ruột già và trực tràng • Bất kỳ số lượng polyp vị thành niên nào ở những bệnh nhân có quá trình di truyền bệnh • Polyp vị thành niên bên ngoài đại tràng (trong dạ dày hoặc ruột non)
H/chứng Peutz–Jeghers	• Ba polyp trở lên đã được xác nhận về mặt mô học • Bất kỳ số lượng polyp nào đặc trưng cho PJS ở bệnh nhân có gánh nặng tiền sử gia đình • Tổn thương da niêm hắc tố điển hình ở bệnh nhân có tiền sử gia đình có • Bất kỳ số lượng polyp nào điển hình cho PJS và tổn thương da niêm mạc hắc tố điển hình
H/c Cowden	**Triệu chứng**: Tổn thương da niêm: Nang tóc, nhú gai, tổn thương nhú, tổn thương niêm mạc
	Tiêu chuẩn chính: K vú, carcinoma tuyến giáp (đặc biệt là nang), đầu to (chu vi trán-chẩm của hộp sọ ≥ 97 bách phân vị), U hạch loạn sản tiểu não, ung thư nội mạc tử cung.
	Tiêu chuẩn phụ: Các tổn thương tuyến giáp khác (giáp phì đại), chậm phát triển tâm thần (IQ ≤75), polyp mô thừa, loạn sản tuyến vú xơ nang, u tuyến, u xơ, ung thư niệu sinh dục
H/c đa polyp hỗn hợp	Thiếu tiêu chuẩn chẩn đoán xác định cho hội chứng Chẩn đoán dựa trên biểu hiện của nhiều polyp thuộc loại mô bệnh học thay đổi

II. BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP POLYP VỊ THÀNH NIÊN

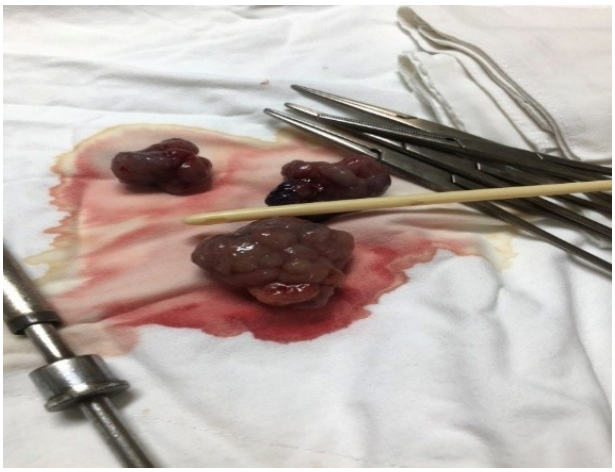
Bệnh nhân nữ 19 tuổi, cư trú tại Huyện An Phú, An Giang; vào viện 08/02/2022 vì đau bụng thượng vị, có khi đau từng cơn, kèm hay nôn, buồn nôn sau ăn. Bệnh đã đau nhiều đợt tương tự, kèm cơ thể gầy sút, cân nặng chỉ 42 kg, da xanh niêm nhợt, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân thiếu máu nặng. Nội soi phát hiện các polyp to ở dạ dày, tá tràng; đại tràng có vài polyp nhỏ hơn. Trước khi mổ đã cắt qua nội soi đại tràng (09/02/2022) và dạ dày (29/01/2022) tổng cộng 12 polyp (7 polyp đại tràng, 5 polyp dạ dày-tá tràng). Chụp CT scan bụng, phát hiện 2 polyp to vùng hỗng tràng gây lồng ruột. Bệnh nhân được truyền máu, tiến hành phẫu thuật nội soi ngày 10/02/2022: mở đường nhỏ kéo đoạn hỗng tràng có polyp gây lồng ruột ra ngoài. Qua lỗ mở hỗng tràng này: cắt 2 polyp to gây lồng ruột; dùng máy soi đại tràng cắt hết các polyp to ở các đoạn ruột non còn lại, lên tới D3 tá tràng (cắt 3 polyp), cũng như khảo sát về hướng hỗng tràng dưới chỗ bán tắc. (Hình 1, 2, 3)



Hình 1: ***Quai ruột được kéo ra: thấy rõ 02 búi lồng với các polyp to trong lòng***



Hình 2: ***Các polyp D3 tá tràng được cắt qua nội soi***



Hình 3: ***Các polyp hỗng tràng được cắt qua nội soi***

BÀN LUẬN

Dựa vào bảng tiêu chuẩn trên, sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, chúng tôi tạm kết luận trường hợp bệnh này thuộc về hội chứng JPS, chứ không phải Hội chứng Peutz–Jeghers (kèm các rối loạn sắc tố niêm mạc miệng), cũng không phải hội chứng Cowden, hội chứng đa polyp hỗn hợp hay hội chứng hamartoma PTEN (thường kèm thêm chứng to đầu, trí tuệ chậm phát triển) nào khác [2], [13]

Theo chúng tôi, khi soi đại tràng, dạ dày gặp nhiều các polyp to nhỏ khác nhau, to bất thường thì nên nghĩ đến bệnh cảnh đa polyp tuyến gia đình, và có thể có thể còn rất nhiều các polyp khác trong lòng ruột non. Cho đến nay, việc khảo sát và cắt các polyp qua nội soi ruột non tại Việt Nam vẫn còn là thách thức do máy móc đắt tiền, (viên nang nội soi, nội soi 02 bóng…), cũng như kỹ thuật cắt các polyp trong ruột non qua nội soi, vấn đề kiểm soát, tái khám…còn gặp nhiều khó khăn. Ở trường hợp của chúng tôi, do polyp hỗng tràng là quá to, gây nên bệnh cảnh bán tắc ruột cao, phát hiện dễ qua siêu âm, ct scan nên điều trị ngoại khoa được đặt ra. Khả năng bỏ sót các polyp ruột non sẽ cao, khi chúng còn nhỏ, chưa gây ra các triệu chứng cơ học, và bác sĩ nội soi chỉ khảo sát và cắt các polyp đại tràng hoặc dạ dày mà thôi.

Do các polyp đã quá to, gây nên bán tắc ruột cơ học, lồng ruột.. nên chỉ định ngoại khoa là cần thiết. Sẽ là bỏ phí cơ hội nếu qua phẫu thuật nội soi mở đường nhỏ, chúng tôi không kết hợp nội soi khảo sát và cắt các polyp khác trong long ruột non, tá tràng D3.. Có rất nhiều bài báo mô tả việc cắt polyp ruột non qua nội soi kết hợp mở đường nhỏ thành bụng [4,5,6] Chúng tôi thấy rằng, việc kết hợp phẫu thuật nội soi, mở đường nhỏ xử lý lồng ruột, và qua lỗ mở ruột non, xử dụng máy nội soi để cắt các polyp cho kết quả tốt, khảo sát hết được chiều dài ruột non.

Theo y văn, thuật ngữ **SILS** (Single Incision Laparoscopic Surgery) là một kỹ thuật được ưa chuộng trong xử lý lồng ruột do polyp to. Trường hợp SILS đầu tiên được báo cáo vào năm 1997. Các quy trình phẫu thuật phức tạp có thể được thực hiện thông qua một vết rạch 2 cm duy nhất bằng cách sử dụng ống nội soi linh hoạt và dụng cụ có khớp nối. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật được đặt qua vết rạch nhỏ này [12]. Trong SILS, kích thước của các cổng và số lượng trocar được giảm xuống để giảm chấn thương thành bụng. Ưu điểm của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bao gồm ít đau sau phẫu thuật, phục hồi nhanh hơn, giảm biến chứng vết mổ và cải thiện kết quả thẩm mỹ [14]. SILS cho phép tiếp cận đầy đủ để khám phá và điều trị polyp ruột non và tránh được phẫu thuật nội soi cổ điển [2,4, 5]. Việc điều trị tắc nghẽn ở những bệnh nhân này được thực hiện bằng cách loại bỏ (các) polyp mô thừa. Phần còn lại của ruột cần được kiểm tra và những polyp được tìm thấy phải được loại bỏ. Điều này có thể được thực hiện trong phẫu thuật với nội soi hỗ trợ nội soi ổ bụng và nội soi đại tràng [4].

Nội soi ruột bằng bóng đôi có hỗ trợ nội soi là một kỹ thuật được phát triển gần đây có thể được sử dụng vừa là công cụ giám sát vừa là công cụ điều trị polyp ruột non ở

bệnh nhân có polyp mô thừa [2,11,15]. Nhưng khi các polyp to, gây tắc nghẽn, một phương pháp kết hợp nội soi và nội soi ổ bụng có thể được sử dụng để điều trị lồng ruột đoạn gần, điều này có thể loại bỏ nhu cầu mổ mở bụng và giảm các biến chứng sau phẫu thuật liên quan đến mổ lại nhiều lần ở nhóm bệnh nhân này [4]. Ngày nay, yêu cầu về phẫu thuật ít xâm lấn, có tính thẩm mỹ cao, phục hồi sớm sau mổ, dẫn đến việc sửa đổi kỹ thuật nội soi thành một quy trình phẫu thuật với một vết mổ nhỏ, phổ biến nhất là ở rốn [14] mà cụ thể là SILS. Trên bệnh nhân này, do nội soi dạ dày trước đó quan sát đước các polyp to ở D2, D3 tá tràng, việc thiếu các dụng cụ chuyên cho phẫu thuật nội soi single port, cũng như còn ít kinh nghiệm cho việc cắt các polyp trong ruột non, dù đã áp dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ nội soi tiêu hóa, nên chúng tôi mở đường nhỏ thành bụng bên trái ngang rốn qua phẫu thuật nội soi bụng, nhằm hy vọng sau khi mở lỗ ruột non xử lý polyp gây lồng, việc đưa máy nội soi vào lòng ruột qua góc Treitz để cắt các polyp nơi D3 tá tràng, có lẽ phù hợp và dễ thành công hơn do cùng hướng với cấu trúc giải phẫu.

Nếu chẩn đoán nghĩ đến đa polyp ông tiêu hóa gây bán tắc hoặc tắc ruột, nên điều trị nội soi tắc ruột và nội soi trong phẫu thuật với việc xử dụng kỹ thuật SILS [5, 10]. Phẫu thuật hoặc nội soi ổ bụng kết hợp với nội soi tiêu hóa trong phẫu thuật được khuyến cáo để loại bỏ bất kỳ polyp có triệu chứng nào của ruột non hoặc bất kỳ polyp nào có đường kính lớn hơn 1,5 cm [9].

III. KẾT LUẬN

Trên đây chỉ là trường hợp hiếm gặp một trường hợp đa polyp lành tính ống tiêu hóa, có biến chứng lồng ruột, nên việc phẫu thuật nội soi, mở nhỏ thành bụng cũng như mở lỗ nhỏ ruột non cắt các polyp to, và cũng qua lỗ mở ruột non này, xử dụng máy nội soi tiêu hóa khảo sát và cắt hết các polyp còn lại trong hỗng tràng, cũng như D3 tá tràng, là kỹ thuật không khó, có thể thành công cao. Thách thức đặt ra là việc tái khám, kiểm soát các polyp khác to lên, hoặc xuất hiện trong ruột non, trong suốt cuộc đời của bệnh nhân như thế nào cho hiệu quả, kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Phạm Mạnh Cường , Nguyễn Thị Quỳnh Thơ** " Hội chứng polyp Juvenile". Yhoccongdong.com, http://ghr.nlm.nih.gov/condition/juvenile-polyposis-syndrome
2. **Boseto F, Shi E, Mitchell J, Preddy J, Adams S**. Gastroduodenal intussusception due to Peutz-Jeghers syndrome in infancy. *Pediatr Surg Int.* 2002;**18**:178–80. doi: 10.1007/s003830100693.
3. **Calva D, Howe J.** Juvenile Polyposis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK51310/
4. **Cunningham JD, Vine AJ, Karch L, Aisenberg J.** The role of laparoscopy in the management of intussusception in the Peutz-Jeghers syndrome: case report and review of the literature. *Surg Laparosc Endosc.* 1998;**8**:17–20. doi: 10.1097/00019509-199802000-00005.

5. **Gonzalez AM, Clapp B.** Laparoscopic management of small bowel intussusception in a 16-year-old with Peutz-Jeghers syndrome. *JSLS.* 2008;**12**:332–4

6. **Hasegawa S, Sekka T, Soeda J, Ishizu K, Ito E, Morita S, et al**. Laparoscopic treatment of intestinal intussusception in the Peutz-Jeghers syndrome: case report and review of the literature. *Tokai J Exp Clin Med.* 2006;**31**:150–3.

7. **Macrae MD, Lamont JT, Grover S.** Overview of colon polyps. UpToDate. Feb 2021.

8. Molly M, Cone, MD. **Hamartomatous Polyps and Associated Syndromes. *Clin Colon Rectal Surg* 2016;29:330–335.**

9. **Pitiakoudis M, Mimidis K, Tsaroucha A, Kartalis G, Simopoulos K.** Intussusception of the small bowel due to Peutz-Jeghers syndrome: a case report. *Ann Ital Chir.* 2004;**75**:75–7.

10. **Retrosi G, Nanni L, Vecchio FM, Manzoni C, Canali R, Busato G, et al.** Solitary Peutz-Jeghers polyp in a paediatric patient. *Case Rep Gastroenterol.* 2010;**4**:452–6.

11. **Ross AS, Dye C, Prachand VN.** Laparoscopic-assisted double-balloon enteroscopy for small-bowel polyp surveillance and treatment in patients with Peutz-Jeghers syndrome. *GastrointestEndosc.* 2006;**64**:984–8.

12. **Sharma A, Dahiya P, Khullar R, Soni V, Baijal M, Chowbey PK.** Single-incision laparoscopic surgery (SILS) in biliary and pancreatic diseases. *Indian J Surg.* 2012;**74**:13–21.

13. **Stoi cev Z, Borun P, Hermann J, Krokowicz P, Cichy W, Kubaszewski L, Banasiewicz T, Plawski A.** Hamartomatous polyposis syndromes. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2013, 11:4

14. **Strzałka M, Matyja M, Matłok M, Migaczewski M, Budzyński P, Budzyński A.** Application of the single access technique in laparoscopic surgery. *Pol Przegl Chir.* 2013;**85**:73–7.

Thomson M, Venkatesh K, Elmalik K, Van der Veer W, Jaacobs M. Double balloon enteroscopy in children: diagnosis, treatment, and safety. *World J Gastroenterol.* 2010;**16**:56–62.